AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

ASOFAMECh PERFIL V3



TOMO 08 · HO · REPASO

REPASO DE ÚLTIMA HORA ·

HEMATOLOGÍA

& Oncología Médica

24	8	7
TEMAS · 1 PÁGINA CADA UNO	TEMAS ★★★ SEGÚN PREGUNTAS REALES 2013–2025	DÍAS DE PLAN DE REPASO AL FINAL

Módulo 1 · Medicina Interna · para las últimas semanas antes del EUNACOM

Índice

Cómo usarlo. Un tema por página: lee «Lo que te preguntan», recorre el algoritmo y termina en las trampas y la regla de oro. Después haz las preguntas del Libro Gordo que indica el pie.

★★★ alta · ★★☆ media · ★☆☆ baja — según cuántas preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) hay en los códigos del tema.
Niveles Perfil V3: **Dx** diagnóstico · **Tx** tratamiento · **Seg** seguimiento.

01 Síndromes Anémicos Hipoproliferativos y Carenciales

★☆☆ 8.1. Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario 4
★★☆ 8.2. Perfil de Cinética de Hierro: Ferritina, Transferrina, TIBC y Saturación de Transferrina 5
★★★ 8.3. Anemia Ferropénica: Diagnóstico, Algoritmo Causal (Digestivo, Menstrual, Celíaco) y Terapia Oral vs Endovenosa GES 6
★☆☆ 8.4. Anemia de la Enfermedad Crónica / Inflamación vs Anemia en la Enfermedad Renal Crónica (EPO y Manejo) GES 8
★☆☆ 8.5. Aplasia Medular e Hipofunción Medular Adquirida vs Fármacos Mielotóxicos 9

02 Anemias Macrocíticas, Hemolíticas y Hemoglobinopatías

★★★ 8.6. Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato 10
★★☆ 8.7. Anemia Hemolítica Autoinmune (AHAI: Anticuerpos Calientes IgG vs Crioaglutininas IgM) y Test de Coombs Directo 11
★★☆ 8.8. Esferocitosis Hereditaria, Déficit de G6PD (Favismo) y Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN) 13
★☆☆ 8.9. Talasemias (Rasgo Beta vs Mayor) y Drepanocitosis / Anemia Falciforme (HbS) 14
★★★ 8.10. Microangiopatías Trombóticas (MAT): PTT (Déficit ADAMTS13 / Plasmaféresis) vs SHU 15

03 Hemostasia Primaria, Plaquetas y Coagulopatías

★☆☆ 8.11. Fisiología de la Hemostasia y Evaluación de Laboratorio: Recuento Plaquetario, TP/INR, TTPK y Fibrinógeno 16
★★★ 8.12. Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del Adulto y Niño: Criterios, Sangrado y Terapia GES 17
★★★ 8.13. Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand GES 19
★★☆ 8.14. Coagulopatías Adquiridas: Hepatopatía Crónica, Déficit de Vitamina K y Manejo de Anticoagulantes 21
★☆☆ 8.15. Coagulación Intravascular Diseminada (CID): Criterios ISTH, Sepsis/Obstetricia y Manejo 22

04 Oncohematología: Neoplasias Mieloides y Linfoides

★★★ 8.16. Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante GES 23
★★☆ 8.17. Leucemias Crónicas: Leucemia Mieloide Crónica (LMC, BCR-ABL) vs Leucemia Linfática Crónica (LLC) GES 25
★★★ 8.18. Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular) GES 26
★★☆ 8.19. Mieloma Múltiple: Criterios CRAB, Pico Monoclonal, Gammapatía Monoclonal Incierta (GMSI) GES 28
★☆☆ 8.20. Neoplasias Mieloproliferativas (Policitemia Vera JAK2, TE, Mielofibrosis) y Mielodisplasia 29

05 Urgencias Oncohematológicas, Trombofilias y Medicina Transfusional

★★☆ 8.21. Neutropenia Febril en Oncología: Estratificación MASCC, Monoterapia Antipseudomónica y Urgencia Médica GES 30
★★★ 8.22. Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular 31
★★☆ 8.23. Trombofilias Hereditarias (Factor V Leiden, Protrombina G20210A) y SAF: Cuándo Estudiar y Manejo 32
★☆☆ 8.24. Medicina Transfusional y Manejo de Hemocomponentes: Glóbulos Rojos, Plaquetas, Plasma y Reacciones Adversas 33

Índice · continuación

Números que tienes que saber	34
Fármacos de primera línea	37
GES de la especialidad	38
Plan de repaso de 7 días	40
Índice por prioridad ★	41

BLOQUE 01 · SÍNDROMES ANÉMICOS HIPOPROLIFERATIVOS Y CARENCIALES

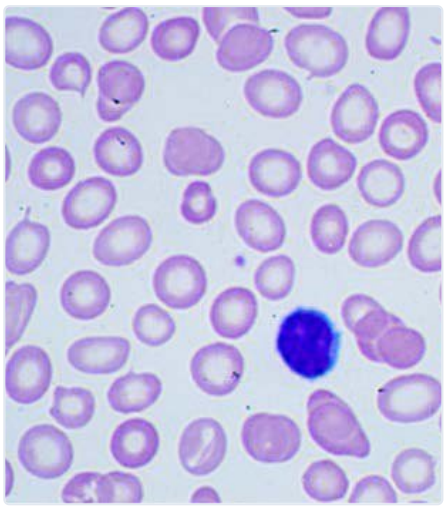
8.1 Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

1.08.4.008 Hemograma — Interpreta y emplea

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Puntos de corte OMS**: Hb < **13 g/dL** en varones y < **12 g/dL** en mujeres adultas no embarazadas.
- El hematocrito aproximado equivale al triple de la hemoglobina (Hto ≈ **3 ×** Hb); en deshidratación el Hto se sobrestima.
- **IRC > 2.0% clasifica la anemia como regenerativa**: las causas son hemólisis o hemorragia aguda reciente.
- **IRC < 2.0% clasifica la anemia como arregenerativa**: abarca anemias carenciales, aplasias y enfermedades crónicas.
- Las pérdidas hemáticas digestivas crónicas son arregenerativas debido a la pérdida concomitante de reservas de hierro.
- Trombocitosis reactiva en el hemograma acompaña frecuentemente a la microcitosis en la anemia ferropénica.



RETICULOCITOS TEÑIDOS
Harrison, Principios de Medicina Interna, Fig. 62-2

ALGORITMO · ENFRENTAMIENTO INICIAL DE LA ANEMIA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

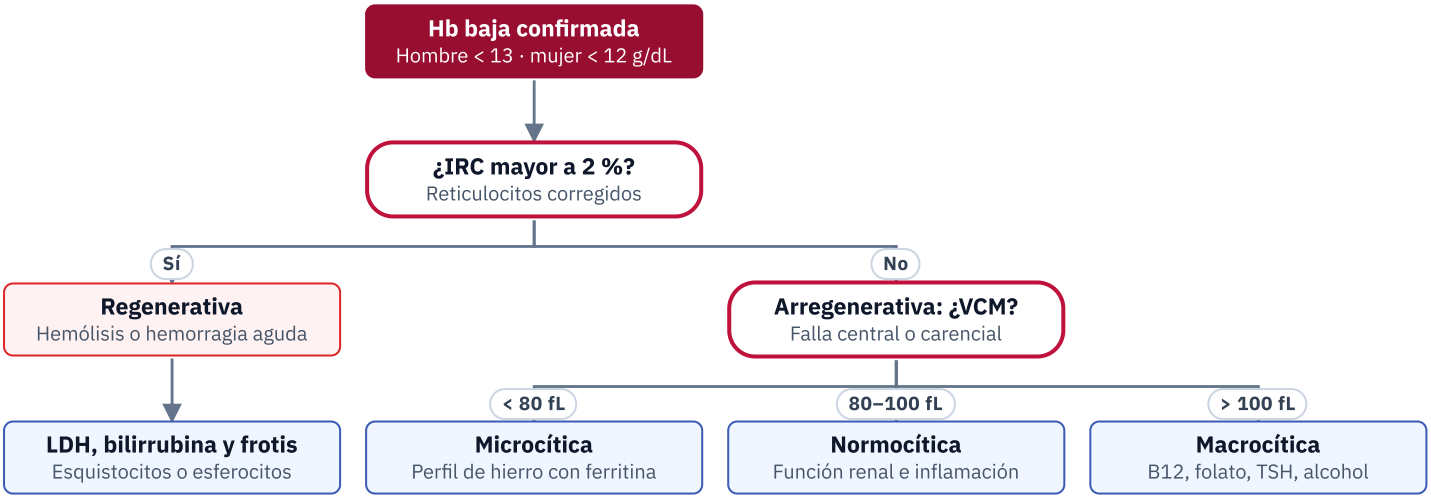


TABLA 8.1 · CLASIFICACIÓN DIAGNÓSTICA DE LAS ANEMIAS SEGÚN VCM E ÍNDICE RETICULOCITARIO

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE HEM-01

CATEGORÍA VCM	RETICULOCITOS (IRC)	ETIOLOGÍAS PRINCIPALES	FROTIS Y MARCADORES CLAVE
Microcítica (< 80 fL)	Arregenerativo (< 2%)	Anemia Ferropénica, Rasgo Talasémico, Anemia Sideroblástica	Hipocromía, microcitosis, poiquilocitosis, RDW aumentado en ferropenia
Normocítica (80-100 fL)	Arregenerativo (< 2%)	Enfermedad Crónica/Inflamatoria, ERC, Mieloma Múltiple, Aplasia	Rouleaux en mieloma; normocromía; ferritina elevada en inflamación
Normocítica (80-100 fL)	Regenerativo (> 2%)	Anemia Hemolítica Aguda, Hemorragia Aguda reciente	Esquistocitos (PTT/SHU), esferocitos (AHAI), policromatofilia intensa
Macrocítica (> 100 fL)	Arregenerativo (< 2%)	Déficit Vitamina B12, Déficit Folato, Consumo Etílico, Hipotiroidismo	Neutrófilos hipersegmentados (pleocariocitos), macroovalocitos
Macrocítica (> 100 fL)	Regenerativo (> 2%)	Crisis hemolítica intensa con reticulocitosis extrema masiva	Los reticulocitos son más voluminosos (>110 fL) y elevan el VCM medido

REGLA DE ORO **Hb < 13 hombre, < 12 mujer** — Embarazo: < 11; manda la Hb, no el Hto

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **1–7** (págs. 6–7) · solucionario págs. 18–19.

Clase 8.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · SÍNDROMES ANÉMICOS HIPOPROLIFERATIVOS Y CARENCIALES

8.2 Perfil de Cinética de Hierro: Ferritina, Transferrina, TIBC y Saturación de Transferrina

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
3 preguntas reales 2013–2025

1.08.1.002 Anemia ferropéni... Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

1.08.1.001 Anemia de las enfer... Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Completo

LO QUE TE PREGUNTAN

- La ferritina sérica < 30 ng/mL es el indicador más confiable de déficit de hierro en ausencia de inflamación.
- **La ferritina es un reactante de fase aguda positivo**: en presencia de PCR elevada, valores < 100 ng/mL aún sugieren ferropenia.
- La transferrina plasmática es un reactante de fase aguda negativo: desciende en sepsis, artritis, cáncer y uremia.
- En la anemia ferropénica pura la transferrina y la TIBC se encuentran elevadas.
- La ferremia aislada carece de valor diagnóstico diferencial debido a sus fluctuaciones y caída tanto en ferropenia como en infección.

ALGORITMO · LECTURA DEL PERFIL DE HIERRO

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

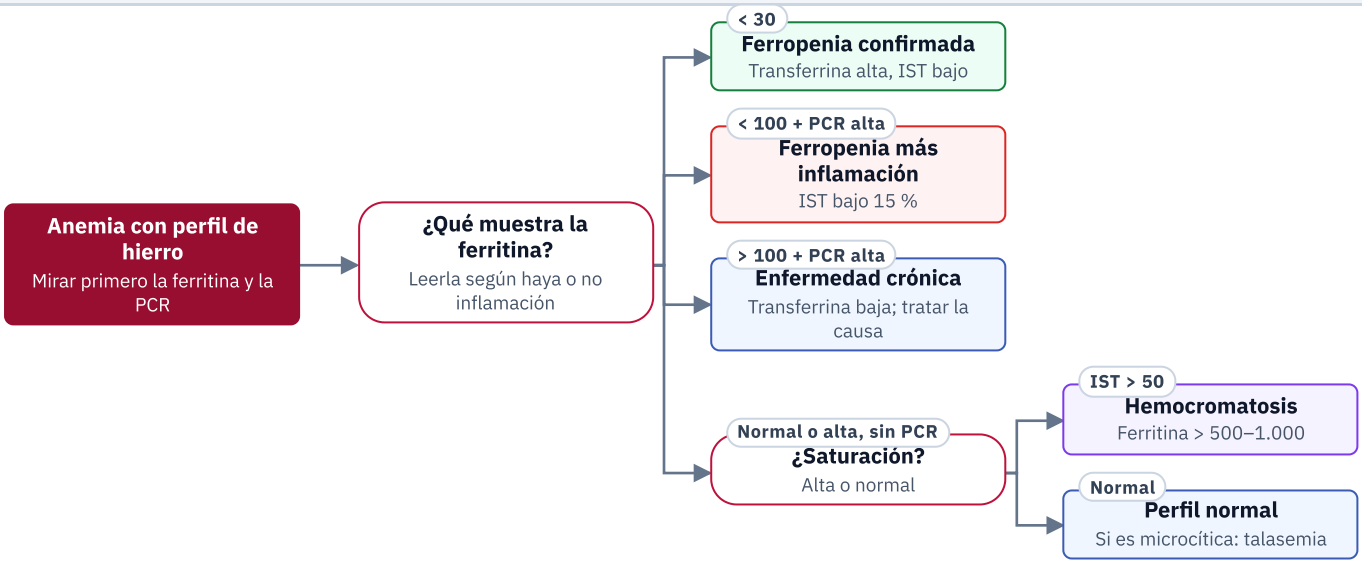


TABLA 8.2 · PATRONES DIAGNÓSTICOS DEL PERFIL MARCIAL EN PATOLOGÍAS FRECUENTES

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE HEM-02

PARÁMETRO	ANEMIA FERROPÉNICA	ANEMIA DE ENFERMEDAD CRÓNICA	HEMOCROMATOSIS HEREDITARIA	RASGO TALASÉMICO MENOR
Ferritina Sérica	Disminuida (< 30 ng/mL)	Elevada (> 100-300 ng/mL)	Muy Elevada (> 500-1.000 ng/mL)	Normal o Ligeramente Elevada
Transferrina / TIBC	Aumentada (Síntesis ↑)	Disminuida (Reactante negativo)	Disminuida o Normal	Normal
Hierro Sérico (Ferremia)	Muy Disminuido	Disminuido (Hierro secuestrado)	Muy Aumentado	Normal
Saturación Transferrina (IST)	Muy Baja (< 15%)	Baja o Normal (15-25%)	Muy Alta (> 50-60%)	Normal (25-40%)
Mecanismo Central	Agotamiento de depósitos	Secuestro marcial por hepcidina	Mutación gen HFE (sobreabsorción)	Mutación cadenas globina (no falta hierro)

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase hem-02

CUADRO	FERRITINA	TRANSFERRINA Y TIBC	SATURACIÓN (IST)
Anemia ferropénica	Baja (< 30 ng/mL)	Aumentada	Muy baja (< 15 %)
Rasgo talasémico menor	Normal o levemente alta	Normal	Normal (25–40 %)
Ferropenia con inflamación	< 100 ng/mL con PCR alta	—	< 15 %

REGLA DE ORO **Ferritina < 30: ferropenia** — Con inflamación, < 100 aún es ferropenia

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **8–12** (pág. 7) · solucionario págs. 19–20.

Clase 8.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · SÍNDROMES ANÉMICOS HIPOPROLIFERATIVOS Y CARENCIALES

TIER 3

8.3 Anemia Ferropénica: Diagnóstico, Algoritmo Causal (Digestivo, Menstrual, Celíaco) y Terapia Oral vs Endovenosa

★★★ PRIORIDAD ALTA
8 preguntas reales 2013–2025

GES Garantía Explícita en Salud (GES): Prevención y Tratamiento Integral en Niños y Gestantes

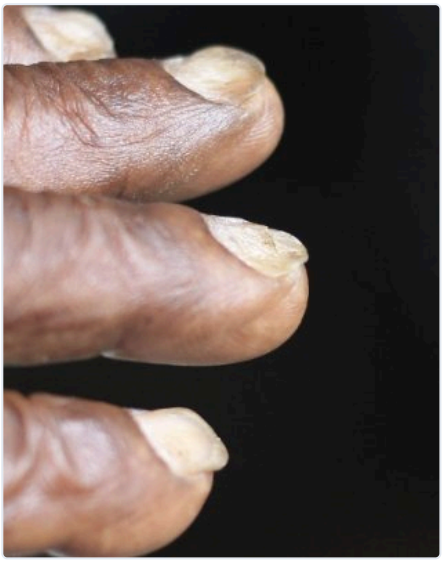
Máxima · Primera causa de anemia en el mundo y en Chile; estudio de hemorragia oculta y esquema de sulfato ferroso

1.08.1.002 Anemia ferropéni... Dx Específico Tx Completo Seg Completo

2.01.1.031 Anemia ferropriva Dx Específico Tx Completo Seg Completo

LO QUE TE PREGUNTAN

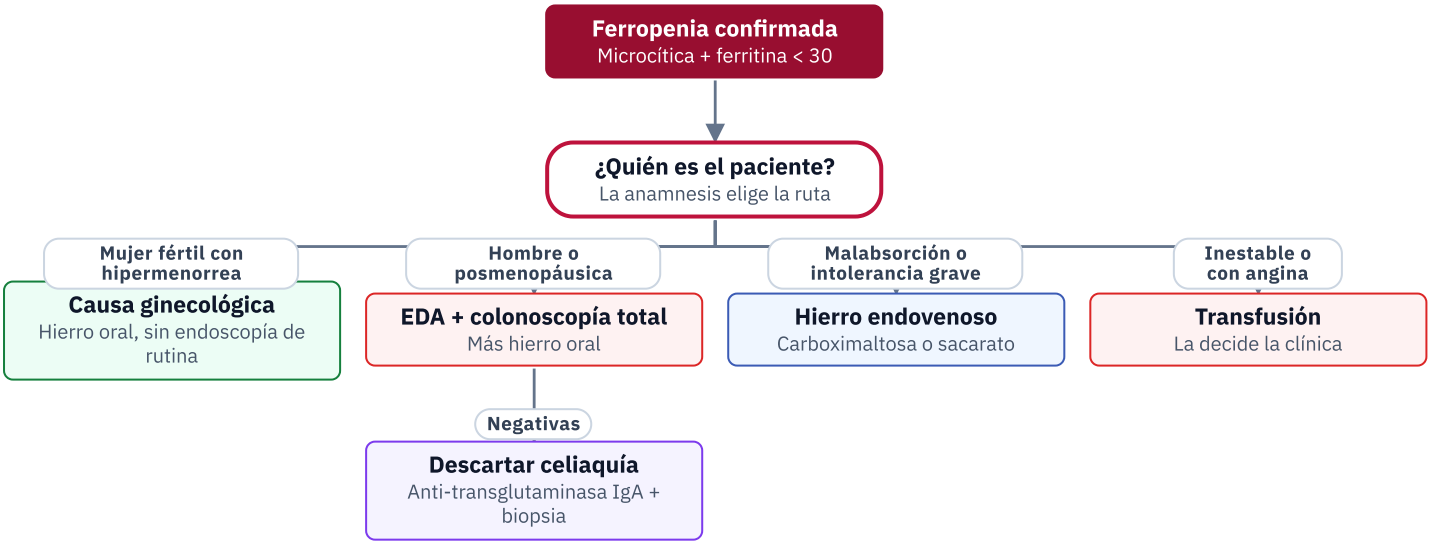
- La causa principal de anemia ferropénica en varones adultos y mujeres posmenopáusicas es el cáncer de colon.
- En mujeres jóvenes con hipermenorrea sin síntomas digestivos la anamnesis ginecológica dirigida suele ser suficiente.
- La ferritina sérica < 30 ng/mL confirma el diagnóstico de ferropenia con máxima sensibilidad y especificidad.
- La dosis moderna de hierro oral es de **40 a 100 mg** de Fe elemental/día o en días alternos para no saturar la hepcidina.
- El sulfato ferroso tiñe las deposiciones de negro; advertir siempre para evitar falsas alarmas de melena.
- La respuesta medular se objetiva al 5°-7° día con el pico de reticulocitos; la Hb se normaliza al 1°-2° mes.
- El hierro oral debe mantenerse durante **3 a 6 meses** tras normalizar la Hb para repletar depósitos de ferritina.



COILONIQUIA
Wikimedia Commons «Koilonychia iron deficiency anemia.jpg», CC BY 2.0, CHeitz

ALGORITMO · ANEMIA FERROPÉNICA: ESTUDIO Y TRATAMIENTO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **13–14** (págs. 7–8) · solucionario pág. 21.

Clase 8.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · SÍNDROMES ANÉMICOS HIPOPROLIFERATIVOS Y CARENCIALES

8.3 Anemia Ferropénica: Diagnóstico, Algoritmo Causal (Digestivo, Menstrual, Celíaco) y Terapia Oral vs Endovenosa

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

★★★ PRIORIDAD ALTA

TABLA 8.3 · COMPARACIÓN TERAPÉUTICA: HIERRO ORAL VS HIERRO ENDOVENOSO EN APS Y HOSPITAL

PARÁMETRO	HIERRO ORAL (SULFATO FERROSO)	HIERRO ENDOVENOSO (CARBOXIMALTOSA / SACARATO)
Indicación Principal	Tratamiento estándar de 1ª línea en ferropenia ambulatoria no complicada	Malabsorción intestinal, EII, bypass gástrico, intolerancia oral grave, ERC en diálisis, 3er trimestre embarazo
Vía y Posología	Oral: 200 mg sulfato ferroso (40-60 mg Fe elemental) 1 vez/día o días alternos	Infusión EV: 500 a 1.000 mg en dilución salina en 15-30 minutos en ambiente monitorizado
Ventajas	Bajo costo, disponibilidad universal en red pública GES/APS, fácil administración	Repleción marcial ultrarrápida, 100% biodisponible, no depende del transporte duodenal
Efectos Adversos	Dispepsia, náuseas, constipación, diarrea, tinción oscura de heces	Cefalea, rubor facial, flebitis local, náuseas transitorias, hipofosfemia leve transitoria
Duración Terapia	Normalización de Hb en 1-2 meses + 3 a 6 meses extra para llenar depósitos	Dosis total calculada por fórmula de Ganzoni administrada en 1 a 2 sesiones

TRAMPAS EUNACOM clase hem-03

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Hombre o posmenopáusica con ferropenia	EDA + colonoscopía total + hierro oral	Solo recetar hierro
Mujer fértil con hipermenorrea, sin síntomas digestivos	Hierro oral y manejo ginecológico	Endoscopía de rutina inmediata
Endoscopías negativas y falla del hierro oral	Anti-transglutaminasa IgA + biopsia duodenal	Subir la dosis de hierro oral

REGLA DE ORO **La ferropenia es un síntoma** — Sangrado o malabsorción

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

La anemia ferropénica es la anemia más frecuente en la práctica médica global y en el examen EUNACOM. El error más grave evaluado en el examen es limitar el manejo a recetar suplementos de hierro sin investigar exhaustivamente la causa de la pérdida. En hombres de cualquier edad y en mujeres posmenopáusicas, la anemia ferropénica debe considerarse secundaria a una neoplasia digestiva oculta (cáncer de colon derecho o gástrico) hasta demostrar lo contrario mediante estudio endoscópico completo.

TABLA 8.3.B · CRONOGRAMA DE RESPUESTA TERAPÉUTICA AL HIERRO Y METAS CLÍNICAS

TIEMPO POSINICIO	PARÁMETRO CLAVE EVALUADO	COMPORTAMIENTO ESPERADO	CONDUCTA MÉDICA
48 a 72 horas	Estado General y Astenia	Mejoría subjetiva precoz por repleción de enzimas tisulares	Reasegurar al paciente y confirmar tolerancia digestiva
5 a 7 días	Recuento de Reticulocitos	Crisis reticulocitaria con pico máximo de reticulocitos	Primer marcador objetivo de respuesta biológica al tratamiento
3 a 4 semanas	Concentración de Hemoglobina	Aumento de Hb en al menos 1.5 a 2.0 g/dL respecto al basal	Si no sube: verificar adherencia, pérdidas persistentes o malabsorción
2 meses	Normalización Hemograma	Normalización de Hb y VCM a rangos de referencia	¡NO SUSPENDER EL HIERRO! Continuar tratamiento de mantención
3 a 6 meses	Ferritina Sérica	Ferritina sérica > 50-100 ng/mL (depósitos repletados)	Momento formal de suspensión del hierro oral y alta hematológica

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **13–14** (págs. 7–8) · solucionario pág. 21.

Clase 8.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · SÍNDROMES ANÉMICOS HIPOPROLIFERATIVOS Y CARENCIALES

TIER 3

8.4 Anemia de la Enfermedad Crónica / Inflamación vs Anemia en la Enfermedad Renal Crónica (EPO y Manejo)

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

GES Garantía Explícita en Salud (GES N° 1): Insuficiencia Renal Crónica Terminal

1.08.1.001 Anemia de las enfer... Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Completo

1.09.1.004 Anemia en nefrópata Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- La anemia de enfermedades crónicas está mediada por hepcidina inducida por IL-6, que degrada la ferroportina.
- **Perfil clásico de la anemia de la inflamación**: ferritina elevada (> 100-300), transferrina baja y ferremia baja.
- La anemia en la ERC se debe primariamente al déficit de síntesis peritubular de eritropoyetina.
- Antes de iniciar eritropoyetina en un paciente renal es obligatorio repletar el hierro (ferritina > 200 ng/mL e IST > **20%**).
- La diana terapéutica de hemoglobina en la ERC con EPO es estrictamente de **10.0 a 11.5 g/dL**.
- Buscar normalizar la hemoglobina a > **12-13 g/dL** en ERC con EPO aumenta el riesgo de ACV, trombosis de fístula y muerte.

ALGORITMO · ANEMIA NORMOCÍTICA ARREGENERATIVA: INFLAMACIÓN O RIÑÓN

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

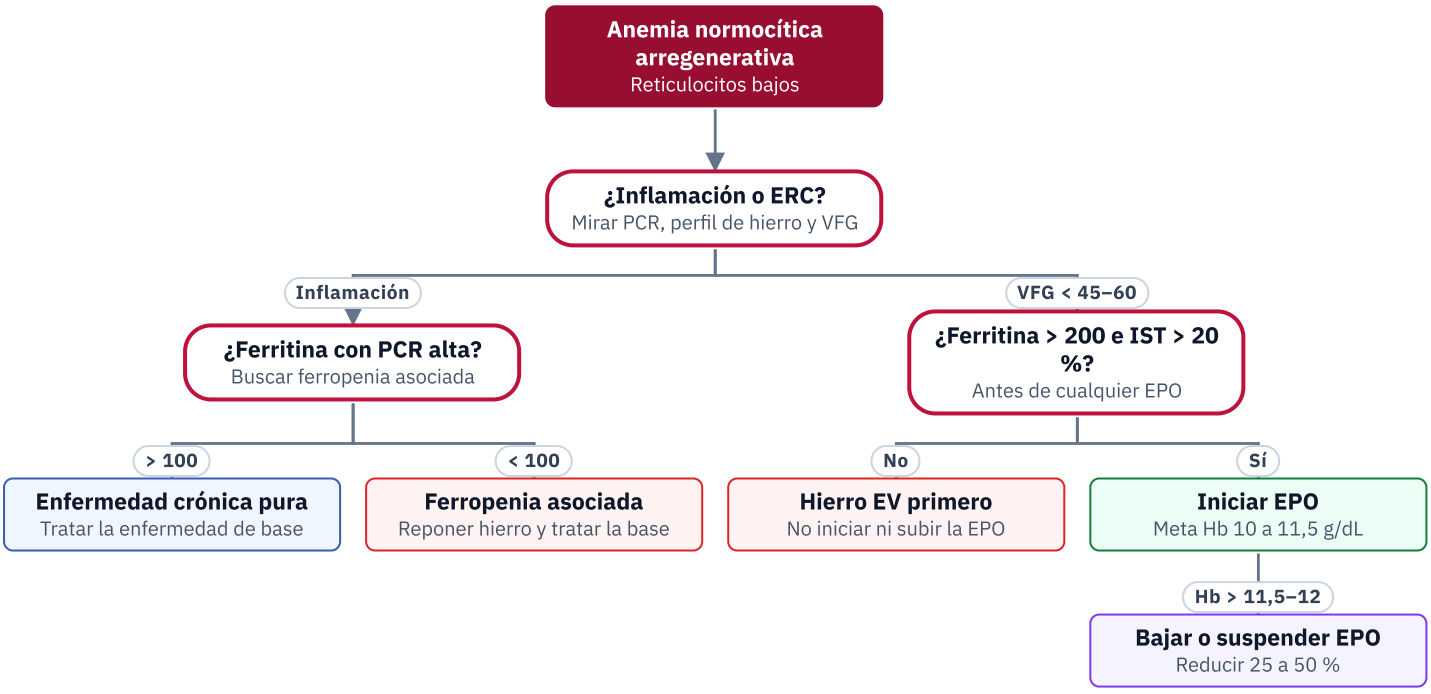


TABLA 8.4 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: ANEMIA FERROPÉNICA VS ENFERMEDAD CRÓNICA VS ERC

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE HEM-04

CARACTERÍSTICA	ANEMIA FERROPÉNICA	ANEMIA DE ENF. CRÓNICAS	ANEMIA RENAL (ERC)
VCM Eritrocitario	Microcítica franca (< 80, fqte < 72 fL)	Normocítica (80-95); microcítica tardía	Normocítica normocrómica pura (80-100 fL)
Ferritina Sérica	Disminuida (< 30 ng/mL)	Elevada (> 100 a 500 ng/mL)	Normal o elevada (según estado inflamatorio)
Transferrina / TIBC	Aumentada (> 360 mg/dL)	Disminuida (< 200 mg/dL)	Normal o disminuida
Saturación Transferrina (IST)	Muy baja (< 15%)	Normal o baja (15-25%)	Normal o baja (evaluar ferropenia funcional)
Mecanismo Central	Falta total de hierro corporal	Secuestro marcial inducido por Hepcidina	Déficit de producción renal de Eritropoyetina
Tratamiento Fundamental	Hierro oral o endovenoso	Tratar la enfermedad inflamatoria de base	Hierro EV (repleción previa) + Eritropoyetina (AEE)

REGLA DE ORO **IL-6 → hepcidina → sin ferroportina** — El hierro queda atrapado

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **15–16** (pág. 8) · solucionario pág. 22.

Clase 8.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · SÍNDROMES ANÉMICOS HIPOPROLIFERATIVOS Y CARENCIALES

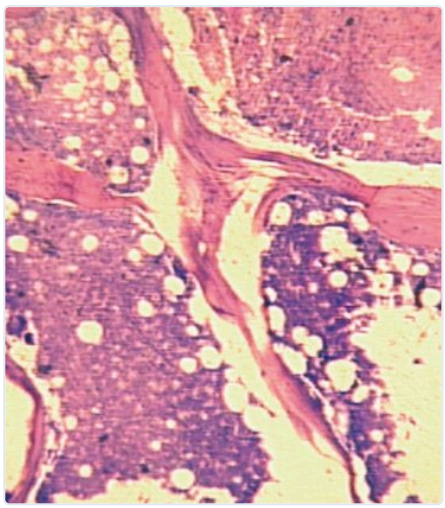
8.5 Aplasia Medular e Hipofunción Medular Adquirida vs Fármacos Mielotóxicos

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

1.08.1.008	Hipofunción medular	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar	1.08.3.003	Efectos mielotóxicos de drogas y medi...	Conocimiento general
1.08.4.003	Biopsia de médula ósea	Emplea informe	1.08.5.001	Biopsia de médula ósea	Derivar a especialista

LO QUE TE PREGUNTAN

- La aplasia medular cursa con pancitopenia en sangre periférica y médula ósea hipocelular (<**25%** celularidad).
- **Signo semiológico de valor diagnóstico crucial**: la aplasia medular NO presenta esplenomegalia ni adenopatías.
- Si hay pancitopenia con esplenomegalia palpable, sospechar hiperesplenismo, cirrosis, leucemia o mielofibrosis.
- **Fármacos clásicos inductores de aplasia**: cloranfenicol, antitiroideos (tiamazol), carbamazepina y quimioterapia.
- **Criterios de gravedad de Camitta**: neutrófilos < 500/uL, plaquetas < 20.000/uL o reticulocitos < 20.000/uL.
- El tratamiento definitivo en pacientes jóvenes (< **40-50 años**) es el trasplante alogénico de médula ósea con donante HLA compatible.



MÉDULA NORMAL
Manual AMIR Hematología, p. 26

ALGORITMO · PANCITOPENIA EN EL ADULTO: SOSPECHA DE APLASIA MEDULAR

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

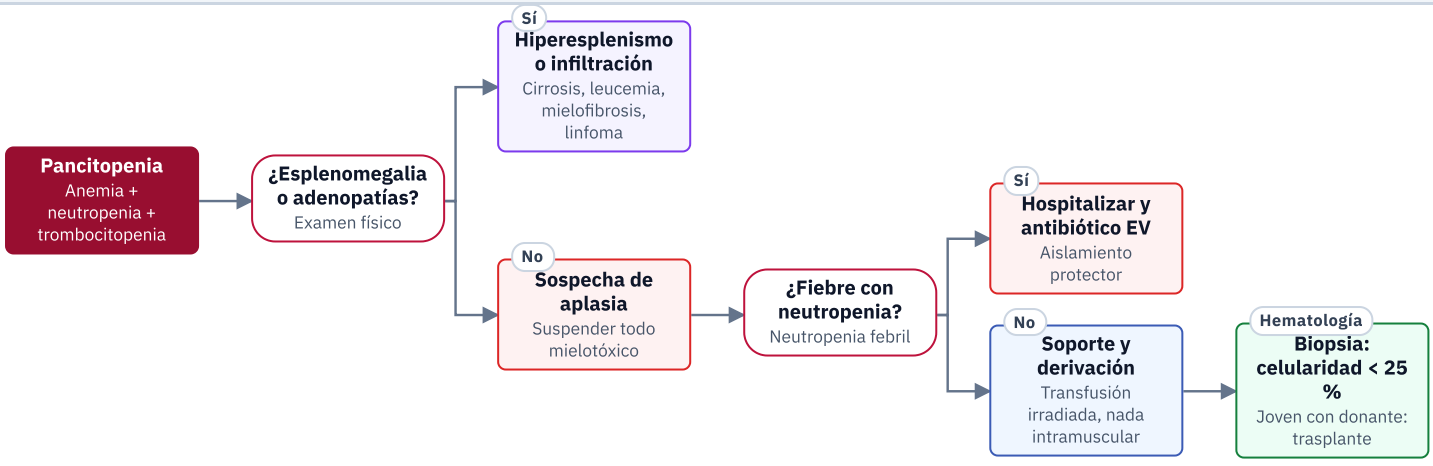


TABLA 8.5 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA PANCITOPENIA EN SANGRE PERIFÉRICA

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE HEM-05

PATOLOGÍA	MÉDULA ÓSEA	ESPLENOMEGALIA	FROTIS PERIFÉRICO	CLAVE DIAGNÓSTICA
Aplasia Medular Adquirida	Hipocelular (<25%), infiltrada por grasa	Ausente (0%)	Pancitopenia sin anomalías morfológicas	Médula vacía sin organomegalia ni blastos
Leucemia Aguda (LMA / LLA)	Hipercelular con > 20% de blastos	Frecuente (especialmente LLA)	Blastos circulantes, bastones de Auer en LMA	Pancitopenia con blastos en frotis periférico
Síndrome Mielodisplásico	Normo o hipercelular con dishemopoyesis	Rara o ausente	Anisocitosis, hipogranulación, neutrófilos Pelger	Displasia celular multilínea en adultos mayores
Mielofibrosis Primaria	Fibrosis reticulínica severa (biopsia seca)	Esplenomegalia masiva	Dacriocitos (células en lágrima), leucoeritroblastosis	Punción aspirativa seca + dacriocitos + bazo gigante
Cirrosis con Hiperesplenismo	Médula normal o hiperplásica reactiva	Presente (Hipertensión portal)	Macrocitosis leve por alcoholismo / daño hepático	Estigmas de hepatopatía crónica + esplenomegalia

REGLA DE ORO **Pancitopenia sin organomegalia** — Aplasia hasta demostrar lo contrario

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **17–18** (pág. 8) · solucionario pág. 23.

Clase 8.5 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · ANEMIAS MACROCÍTICAS, HEMOLÍTICAS Y HEMOGLOBINOPATÍAS TIER 3

8.6 Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato

★★★ PRIORIDAD ALTA
11 preguntas reales 2013–2025

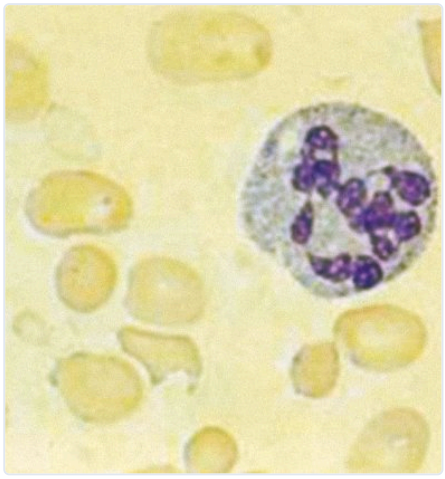
1.08.1.004 Anemia megaloblásti... Dx Sospecha Tx Inicial Seg Completo

1.08.3.001 Alcoholismo y asociación con carencia... Conocimiento general

1.10.1.023 Síndromes sensitiv... Dx Sospecha Tx Inicial Seg No requiere

LO QUE TE PREGUNTAN

- El déficit de vitamina B12 produce afectación neurológica (degeneración combinada subaguda); el déficit de folatos NO.
- La degeneración combinada subaguda afecta cordones posteriores (propiocepción/vibración) y laterales (Babinski/espasticidad).
- El ácido metilmalónico sérico está elevado en el déficit de B12 y es rigurosamente normal en el déficit de ácido fólico.
- **Peligro de examen**: administrar ácido fólico aislado en déficit de B12 empeora irreversiblemente el daño neurológico.
- La anemia perniciosa se debe a gastritis atrófica autoinmune con anticuerpos anti-factor intrínseco y riesgo de cáncer gástrico.
- La absorción de B12 ocurre en el íleon terminal acoplada al factor intrínseco; el folato se absorbe en el yeyuno proximal.



FROTIS MEGALOBLÁSTICO
Manual AMIR Hematología, p. 29

ALGORITMO · ANEMIA MACROCÍTICA: B12, FOLATO Y LA TRAMPA DEL ÁCIDO FÓLICO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

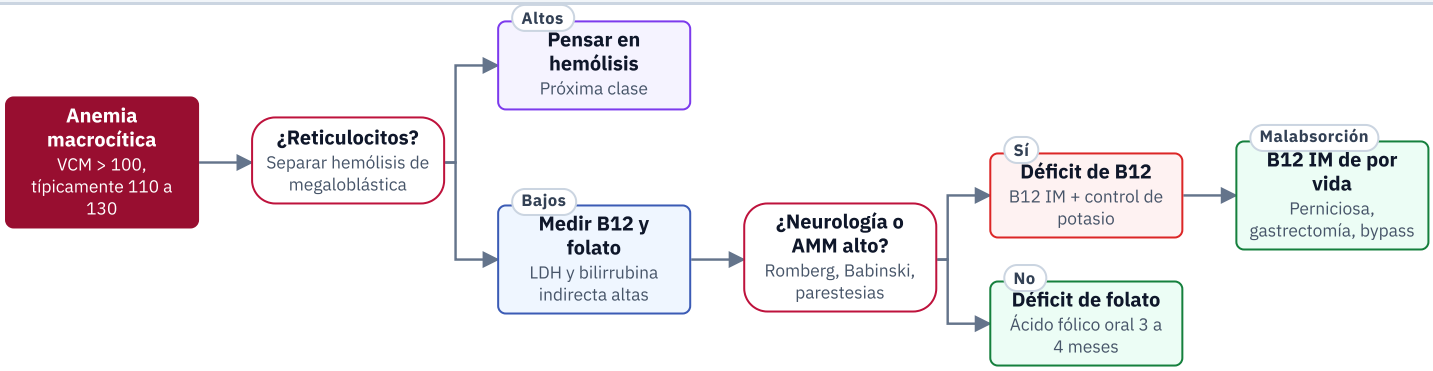


TABLA 8.6 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: DÉFICIT DE VITAMINA B12 VS DÉFICIT DE ÁCIDO FÓLICO

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE HEM-06

CARACTERÍSTICA	DÉFICIT DE VITAMINA B12 (COBALAMINA)	DÉFICIT DE ÁCIDO FÓLICO (FOLATOS)
Fuente Nutricional	Exclusivamente origen animal (carnes, huevos, lácteos)	Vegetales verdes frescos, legumbres, cítricos, hígado
Sitio de Absorción	Íleon terminal (unido obligatoriamente a Factor Intrínseco)	Yeyuno proximal (absorción activa y pasiva rápida)
Tiempo de Agotamiento	3 a 5 años (reservas hepáticas masivas: 3-5 mg)	3 a 4 meses (reservas hepáticas escasas: 5-10 mg)
Compromiso Neurológico	Presente: Degeneración combinada subaguda, ataxia, parestesias	Ausente por completo (no causa daño medular mielínico)
Ácido Metilmalónico Sérico	Marcadamente ELEVADO (Patognomónico del déficit de B12)	Estrictamente NORMAL
Homocisteína Plasmática	Elevada (Metionina sintasa bloqueada)	Elevada (Metionina sintasa bloqueada)
Etiología Principal	Anemia perniciosa, gastrectomía, bypass gástrico, resección ileal	Alcoholismo crónico, desnutrición, metotrexato, embarazo
Tratamiento Estándar	Cianocobalamina 1.000 ug IM (mensual de por vida si malabsorción)	Ácido fólico 1 a 5 mg/día vía oral durante 3 a 4 meses

REGLA DE ORO **VCM > 110, LDH alta, reticulocitos bajos** — Hemólisis intramedular, no periférica

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **21–28** (págs. 8–9) · solucionario págs. 25–26.

Clase 8.6 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · ANEMIAS MACROCÍTICAS, HEMOLÍTICAS Y HEMOGLOBINOPATÍAS TIER 3

8.7 Anemia Hemolítica Autoinmune (AHAI: Anticuerpos Calientes IgG vs Crioaglutininas IgM) y Test de Coombs Directo

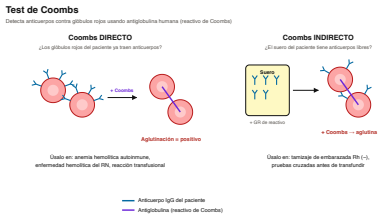
PRIORIDAD MEDIA
3 preguntas reales 2013–2025

Alta · Tríada de hemólisis (ictericia, anemia, orina oscura), Coombs directo, corticoterapia de 1ª línea y rituximab

1.08.1.003	Anemia hemolítica	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar	
1.08.4.010	Pruebas de hemólisis	Interpreta y emplea	

LO QUE TE PREGUNTAN

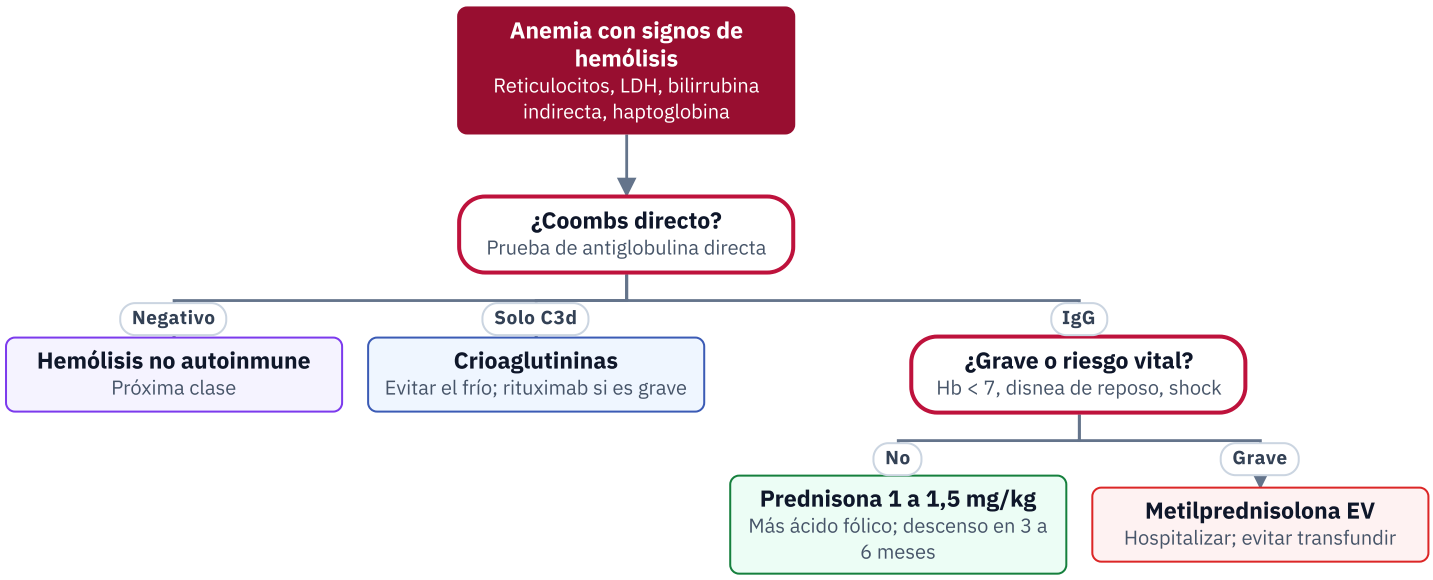
- **Tríada cardinal de hemólisis**: anemia regenerativa (reticulocitos >**2%**), ictericia flavínica indirecta y LDH elevada.
- La haptoglobina colapsada (< **10 mg/dL**) es el marcador más sensible de hemólisis intravascular y extravascular masiva.
- La Prueba de Coombs Directa positiva para IgG confirma AHAI por anticuerpos calientes (extravascular en bazo).
- El tratamiento de primera línea para AHAI por anticuerpos calientes es la corticoterapia sistémica (prednisona **1-1.5 mg/kg**/día).
- En AHAI caliente todas las unidades de banco de sangre resultan "incompatibles"; solo transfundir ante compromiso vital inminente.
- La AHAI por crioaglutininas (IgM / C3d) no responde a corticoides ni esplenectomía; se maneja evitando el frío y con rituximab.
- Enfermedad por crioaglutininas se asocia a neumonía por Mycoplasma pneumoniae, virus de Epstein-Barr y linfomas.



PRUEBA DE COOMBS
Dibujo propio (esquema)

ALGORITMO · ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOINMUNE: CONFIRMAR, CLASIFICAR Y TRATAR

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **29–32** (págs. 9–10) · solucionario págs. 26–27.

Clase 8.7 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · ANEMIAS MACROCÍTICAS, HEMOLÍTICAS Y HEMOGLOBINOPATÍAS

8.7 Anemia Hemolítica Autoinmune (AHAI: Anticuerpos Calientes IgG vs Crioaglutininas IgM) y Test de Coombs Directo

PRIORIDAD MEDIA

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

TABLA 8.7 · COMPARACIÓN INMUNOLÓGICA Y CLÍNICA: AHAI POR ANTICUERPOS CALIENTES VS CRIOAGLUTININAS — = TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE HEM-07

PARÁMETRO	AHAI POR ANTICUERPOS CALIENTES	ENFERMEDAD POR CRIOAGLUTININAS (FRÍOS)
Frecuencia Relativa	80% a 90% de todos los casos de AHAI	10% a 15% de los casos
Isotipo de Autoanticuerpo	IgG monomérico (rara vez IgA)	IgM pentamérico fijador de complemento
Temperatura Óptima	37 °C (temperatura corporal central)	0 °C a 4 °C (temperatura en lechos acrales fríos)
Sitio Principal de Lisis	Extravascular en Bazo (por macrófagos Fc-gamma)	Intravascular periférica y Extravascular en Hígado (C3b)
Frotis Sanguíneo	Microesferocitos abundantes, policromatofilia	Aglutinación de hematíes en pilas ("rouleaux anómalo")
Resultado Coombs Directo	Positivo para IgG (+/- complemento C3d)	Positivo exclusivamente para C3d (IgG negativo)
Asociaciones Clínicas	Idiopática, LES, LLC, linfomas, fármacos (cefalosporinas)	Mycoplasma pneumoniae, VEB (mononucleosis), linfoma B
Tratamiento de 1ª Línea	Corticoides sistémicos (Prednisona 1-1.5 mg/kg/día)	Evitar el frío ambiental estrictamente; Rituximab (No esteroides)

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA — clase hem-07

PARÁMETRO	AHAI CALIENTE	CRIOAGLUTININAS
Anticuerpo y temperatura	IgG a 37 °C	IgM a 0–4 °C
Transfusión	Solo con riesgo vital	Pruebas cruzadas siempre incompatibles

REGLA DE ORO — **Reticulocitos altos, LDH alta** — Bilirrubina indirecta alta, haptoglobina baja

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

La anemia hemolítica autoinmune (AHAI) representa una de las emergencias médicas más desafiantes en medicina interna. El EUNACOM exige el reconocimiento instantáneo del patrón biológico de hemólisis (reticulocitos altos, hiperbilirrubinemia indirecta, LDH marcadamente elevada y colapso de la haptoglobina plasmática). La Prueba de Coombs Directa es el examen confirmatorio de elección para AHAI por anticuerpos calientes. El médico general debe dominar el inicio precoz de corticoides sistémicos y recordar la máxima advertencia transfusional: las pruebas cruzadas siempre serán incompatibles, por lo que la transfusión de glóbulos rojos se reserva exclusivamente para inestabilidad hemodinámica vital.

TABLA 8.7.B · ESCALAMIENTO FARMACOLÓGICO EN LA ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOINMUNE POR IGG

LÍNEA TERAPÉUTICA	FÁRMACO / PROCEDIMIENTO	DOSIS Y MECANISMO	EFICACIA Y TIEMPO DE RESPUESTA
Primera Línea Estándar	Prednisona vía oral	1.0 a 1.5 mg/kg/día (disminución lenta en 3-6 meses)	Respuesta en 70-80% de casos al cabo de 1 a 2 semanas
Primera Línea Urgencia	Metilprednisolona endovenosa	Pulsos de 500 a 1.000 mg/día EV por 3 días consecutivos	Acción rápida en crisis hemolítica aguda descompensada
Segunda Línea Monoclonal	Rituximab (Anti-CD20)	375 mg/m² EV semanal por 4 semanas (elimina linfocitos B)	Respuesta en 70-90% de corticorrefractarios en 3-6 semanas
Segunda Línea Quirúrgica	Esplenectomía laparoscópica	Resección del bazo (elimina el sitio de hemólisis extravascular)	Remisión en 60-70%; exige vacunación contra encapsulados
Soporte Hematopoyético	Ácido Fólico vía oral	5 mg/día VO permanente durante la fase hemolítica activa	Previene crisis megaloblástica por consumo de folatos

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **29–32** (págs. 9–10) · solucionario págs. 26–27.

Clase 8.7 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · ANEMIAS MACROCÍTICAS, HEMOLÍTICAS Y HEMOGLOBINOPATÍAS

8.8 Esferocitosis Hereditaria, Déficit de G6PD (Favismo) y Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN)

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
3 preguntas reales 2013–2025

1.08.1.003	Anemia hemolítica	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar	1.08.4.010	Pruebas de hemólisis	Interpreta y emplea

LO QUE TE PREGUNTAN

- La esferocitosis hereditaria es la causa más común de anemia hemolítica congénita; herencia autosómica dominante.
- **Tríada de esferocitosis**: anemia hemolítica, colelitiasis pigmentaria en jóvenes y esplenomegalia con Coombs negativo.
- El aumento de la Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media (CHCM > **36 g/dL**) es patognomónico de esferocitosis.
- El tratamiento curativo de la esferocitosis es la esplenectomía electiva, siempre diferida > **5 años** y posvacunación.
- **Déficit de G6PD**: ligado al X, cursa con cuerpos de Heinz y células mordidas tras habas, primaquina o sulfonamidas.
- La medición cuantitativa de G6PD debe realizarse varias semanas después de la crisis hemolítica aguda.



ESFEROCITOS
Manual AMIR Hematología, p. 34

ALGORITMO · ANEMIA HEMOLÍTICA: DEL COOMBS AL DEFECTO INTRÍNSECO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

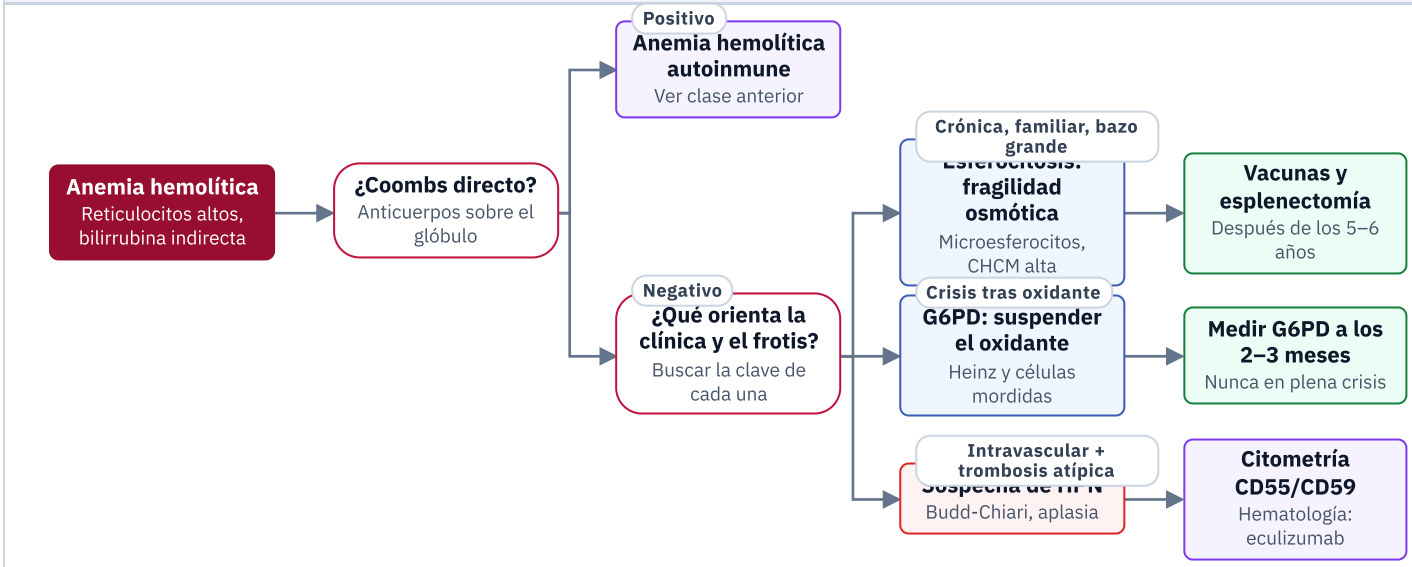


TABLA 8.8 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: ESFEROCITOSIS HEREDITARIA VS DÉFICIT DE G6PD VS HPN

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE HEM-08

CRITERIO	ESFEROCITOSIS HEREDITARIA	DÉFICIT DE G6PD	HEMOGLOBINURIA PAROXÍSTICA NOCTURNA
Mecanismo Patogénico	Defecto citoesqueleto (anquirina/espectrina)	Déficit enzimático (defensa antioxidante)	Mutación somática gen PIGA (déficit anclaje GPI)
Patrón de Herencia	Autosómica dominante (75%)	Recesiva ligada al cromosoma X	Adquirida clonal no hereditaria
Hallazgo en Frotis	Microesferocitos densos, sin halo central	Cuerpos de Heinz y células mordidas (degmacitos)	Pancitopenia leve a moderada sin anomalía morfológica
Test Confirmatorio	Prueba Fragilidad Osmótica / Eosina-5-maleimida	Dosificación enzimática cuantitativa de G6PD	Citometría de flujo para CD55 y CD59
Clave Clínica de Examen	Colelitiasis en adolescente + bazo palpable + CHCM ↑	Crisis hemolítica tras habas, sulfas o primaquina	Hemólisis intravascular + trombosis atípica (Budd-Chiari)
Terapia Específica	Esplenectomía electiva (posvacunación encapsulados)	Evitar oxidantes (habas/fármacos); soporte en crisis	Eculizumab (anti-C5) / Trasplante alogénico

REGLA DE ORO **Colelitiasis joven + bazo + CHCM alta** — Confirmar con fragilidad osmótica

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **33–34** (pág. 10) · solucionario págs. 27–28.

Clase 8.8 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · ANEMIAS MACROCÍTICAS, HEMOLÍTICAS Y HEMOGLOBINOPATÍAS

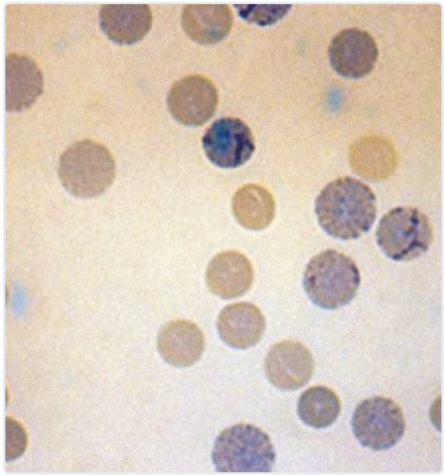
8.9 Talasemias (Rasgo Beta vs Mayor) y Drepanocitosis / Anemia Falciforme (HbS)

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
2 preguntas reales 2013–2025

1.08.1.003 Anemia hemolítica — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Rasgo talasémico menor**: microcitosis extrema (VCM < 70) con GR elevados (>5 mill), RDW normal y ferritina normal.
- **Índice de Mentzer**: VCM / recuento de glóbulos rojos (en millones). Si es < 13 orienta a talasemia; si > 13 a ferropenia.
- La confirmación diagnóstica del rasgo talasémico beta se realiza con electroforesis de hemoglobina: HbA2 > **3.5%**.
- **¡Error grave EUNACOM!**: recetar hierro a un paciente talasémico genera hemosiderosis secundaria innecesaria.
- La drepanocitosis se debe a sustitución de ácido glutámico por valina en la cadena beta (HbS), polimerizando en hipoxia.
- **Complicaciones de la drepanocitosis**: crisis vasooclusivas dolorosas, síndrome torácico agudo y autoesplenectomía.



CUERPOS DE HEMOGLOBINA H
Manual AMIR Hematología, p. 37

ALGORITMO · MICROCITOSIS: ¿FERROPENIA O RASGO TALASÉMICO?

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

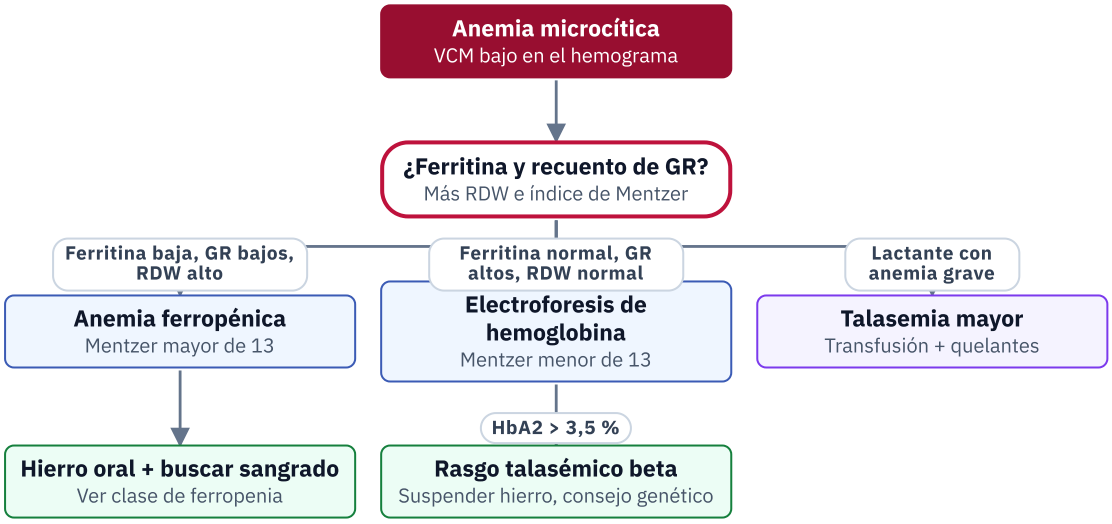


TABLA 8.9 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: ANEMIA FERROPÉNICA VS RASGO TALASÉMICO MENOR

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE HEM-09

PARÁMETRO ANALÍTICO	ANEMIA FERROPÉNICA	RASGO TALASÉMICO BETA MENOR
Volumen Corpuscular Medio (VCM)	Disminuido (< 80 fL), proporcional a la anemia	Marcadamente disminuido (< 70 fL), desproporcionado
Recuento de Glóbulos Rojos	Disminuido (< 4.0 millones/uL)	Normal o Aumentado (> 5.0 a 5.5 millones/uL)
Índice de Mentzer (VCM / Millones GR)	> 13 (orienta a ferropenia)	< 13 (orienta fuertemente a talasemia)
Amplitud Distribución Eritrocitaria (RDW)	Elevada (> 15%, anisocitosis marcada)	Normal (11.5 a 14.5%, microcitosis homogénea)
Ferritina Sérica	Disminuida (< 30 ng/mL)	Estrictamente normal o ligeramente aumentada
Electroforesis de Hemoglobina	Normal (HbA1 97%, HbA2 < 3%)	Elevación de Hemoglobina A2 (> 3.5%)
Conducta Terapéutica	Suplementar con hierro oral y buscar causa sangrado	Asesoría genética; ¡Contraindicado dar hierro oral!

REGLA DE ORO **Microcitosis desproporcionada** — GR altos, RDW y ferritina normales

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **35–36** (pág. 10) · solucionario págs. 28–29.

Clase 8.9 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · ANEMIAS MACROCÍTICAS, HEMOLÍTICAS Y HEMOGLOBINOPATÍAS

8.10 Microangiopatías Trombóticas (MAT): PTT (Déficit ADAMTS13 / Plasmaféresis) vs SHU

★★★ PRIORIDAD ALTA
11 preguntas reales 2013–2025

1.08.1.012	Púrpuras trombopénicos	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar
2.01.1.067	Síndrome hemolítico u...	Dx Específico	Tx Inicial	Seg Derivar
1.08.1.003	Anemia hemolítica	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- La PTT se produce por déficit severo (<**10%**) de ADAMTS13, acumulando multímeros gigantes de factor von Willebrand.
- **Bíada suficiente para sospechar e iniciar tratamiento de PTT**: anemia hemolítica microangiopática + plaquetopenia de consumo.
- **Péntada clásica de Moschcowitz**: plaquetopenia, anemia con esquistocitos, clínica neurológica, fiebre y falla renal.
- **Diferencia clave con la CID**: en la PTT y en el SHU el TP, el TTPK y el fibrinógeno son rigurosamente NORMALES.
- El tratamiento de emergencia vital de la PTT es la Plasmaféresis (recambio plasmático terapéutico diario) más corticoides.



PETEQUIAS
Manual AMIR Hematología, p. 89

ALGORITMO · SOSPECHA DE MICROANGIOPATÍA TROMBÓTICA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

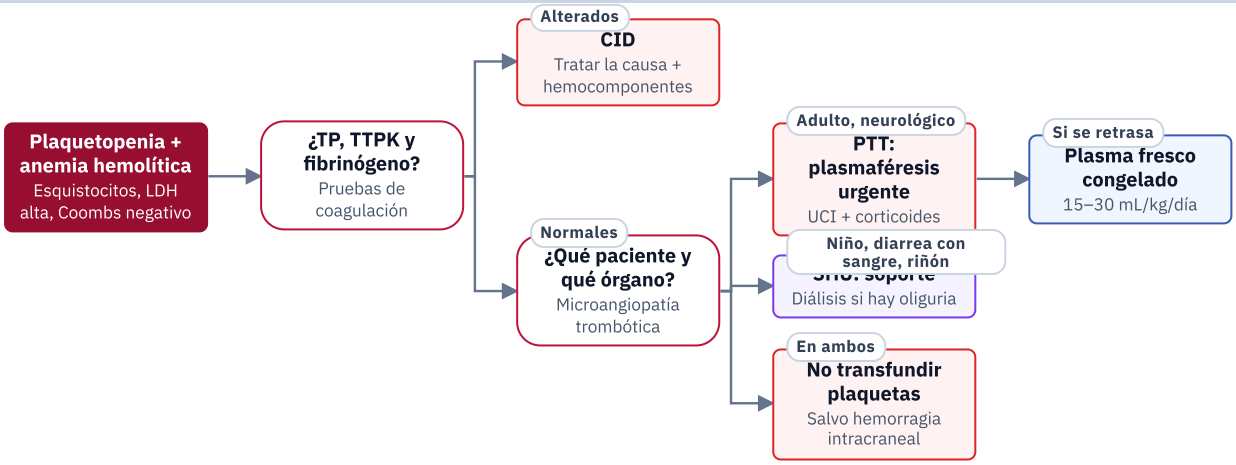


TABLA 8.10 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: PTT VS SHU TÍPICO VS COAGULACIÓN INTRAVASCULAR DISEMINADA (CID)

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE HEM-10

PARÁMETRO	PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA TROMBÓTICA (PTT)	SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO (SHU)	COAGULACIÓN INTRAVASCULAR DISEMINADA (CID)
Población Típica	Adultos (predominio mujeres jóvenes 20-50 años)	Pediátrica (lactantes y niños pequeños 1-5 años)	Cualquier edad en paciente crítico séptico / politraumatizado
Mecanismo Central	Déficit severo de ADAMTS13 (<10%) por autoanticuerpos	Daño endotelial por Toxina Shiga (E. coli O157:H7)	Activación masiva de trombina y consumo de factores
Órgano Dominante	Sistema Nervioso Central (fluctuante, afasia, coma)	Riñón (injuria renal aguda oligoanúrica grave)	Sistémico multiorgánico (hemorragia + trombosis microvascular)
Pruebas Coagulación (TP / TTPK)	ESTRICTAMENTE NORMALES (no se consumen factores)	ESTRICTAMENTE NORMALES	PROLONGADAS (TP ↑, TTPK ↑, Fibrinógeno ↓, Dímero D ↑↑)
Esquistocitos en Frotis	Presentes y abundantes (> 1-2%)	Presentes y abundantes	Presentes en cantidad variable
Tratamiento Cardinal	Plasmaféresis diaria urgente + Corticoides + Rituximab	Soporte hidroelectrolítico + diálisis si oliguria	Tratar la sepsis/causa + Hemocomponentes (PFC/crioprecipitado)

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase hem-10

PARÁMETRO	PTT	SHU TÍPICO	CID
Paciente	Adulto, mujer 20–50 años	Niño de 1–5 años	Crítico: sepsis, trauma
Error frecuente	Transfundir plaquetas	Transfundir plaquetas	Olvidar la causa

REGLA DE ORO **Esquistocitos + plaquetas bajas** — Basta para sospechar una MAT

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **19–20** (pág. 8) · solucionario pág. 24.

Clase 8.10 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · HEMOSTASIA PRIMARIA, PLAQUETAS Y COAGULOPATÍAS

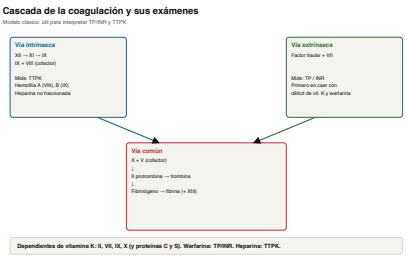
8.11 Fisiología de la Hemostasia y Evaluación de Laboratorio: Recuento Plaquetario, TP/INR, TTPK y Fibrinógeno

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
2 preguntas reales 2013–2025

1.08.4.005	Estudio de coagulopatías	Interpreta y emplea	1.08.4.007	Estudio de trombopatías	Interpreta y emplea
4.01.4.013	Pruebas de coagulación	Interpreta y emplea	2.01.4.021	Pruebas de coagulación	Interpreta y emplea

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Hemostasia primaria (plaquetas/vWF)**: sangrado mucocutáneo inmediato (petequias, epistaxis, gingivorragia).
- **Hemostasia secundaria (factores)**: sangrado profundo tardío (hematomas musculares y hemartrosis articulares).
- El TP/INR evalúa la vía extrínseca y común; la prolongación aislada del TP se debe a déficit del Factor VII.
- El Factor VII tiene la vida media plasmática más corta (**4-6 h**), por lo que el TP es el primero en alterarse en daño hepático y acenocumarol.
- El TTPK evalúa la vía intrínseca y común; se altera en Hemofilia A (FVIII), Hemofilia B (FIX) y heparina.
- **La Prueba de Mezcla 1**:1 con plasma normal diferencia déficit de factores (corrige TTPK) de inhibidores circulantes (no corrige).



VÍAS Y EXÁMENES
Dibujo propio (esquema)

ALGORITMO · PRUEBAS DE COAGULACIÓN: LEER EL PATRÓN

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

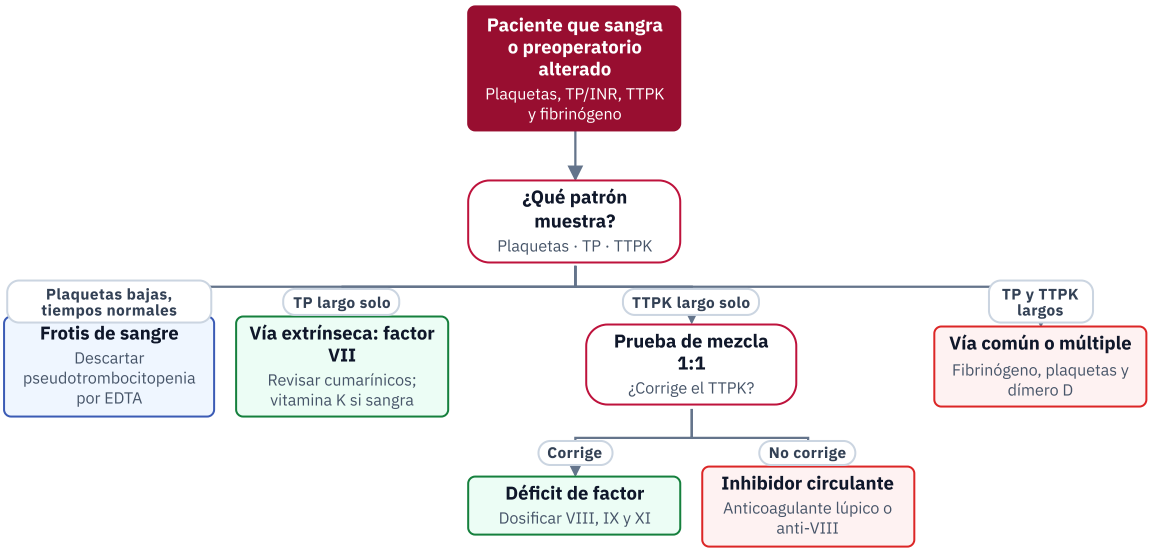


TABLA 8.11 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE ALTERACIONES EN LAS PRUEBAS DE COAGULACIÓN

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE HEM-11

PATRÓN ANALÍTICO	VÍA DE COAGULACIÓN AFECTADA	ETIOLOGÍAS PRINCIPALES FRECUENTES	CONDUCTA DIAGNÓSTICA INMEDIATA
TP prolongado / TTPK normal	Vía Extrínseca (Factor VII)	Uso de Cumarínicos (Acenocumarol), Déficit inicial Vitamina K, Hepatopatía leve	Evaluar ingesta de fármacos; administrar Vitamina K si sangrado
TTPK prolongado / TP normal	Vía Intrínseca (VIII, IX, XI, XII)	Hemofilia A/B, Enf. von Willebrand, Heparina no fraccionada, Anticoagulante lúpico	Realizar Prueba de Mezcla 1:1; si corrige, dosificar factores VIII y IX
TP y TTPK ambos prolongados	Vía Común (X, V, II, I) o Múltiple	Hepatopatía crónica severa, CID, déficit masivo Vit K, sobredosis de ACODs (Rivaroxabán)	Dosificar Fibrinógeno, Plaquetas y Dímero D para descartar CID
Plaquetas bajas / TP y TTPK normales	Hemostasia Primaria exclusiva	Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI), hiperesplenismo, toxicidad medular	Revisar frotis de sangre para descartar pseudotrombocitopenia por EDTA

REGLA DE ORO **Petequias y mucosas: plaquetas** — Hemostasia primaria

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **39–40** (pág. 11) · solucionario pág. 30.

Clase 8.11 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · HEMOSTASIA PRIMARIA, PLAQUETAS Y COAGULOPATÍAS TIER 3

8.12 Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del Adulto y Niño: Criterios, Sangrado y Terapia GES

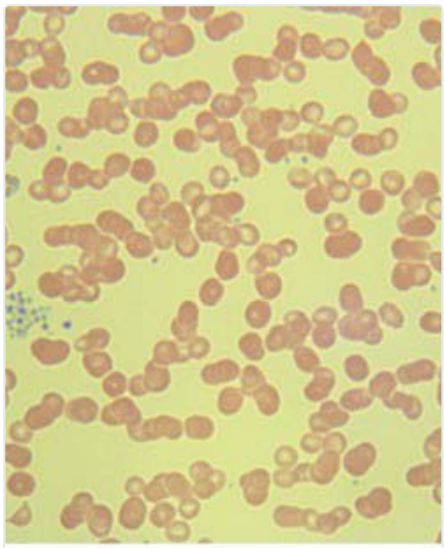
★★★ PRIORIDAD ALTA
13 preguntas reales 2013–2025

Máxima · Diagnóstico de exclusión en paciente con sangrado mucocutáneo sin esplenomegalia, corticoterapia e IgEV

1.08.1.012	Púrpuras trombopénicos	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar
1.08.2.009	Trombopenia severa	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar
2.01.1.035	Síndrome purpúrico	Dx Específico	Tx Inicial	Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

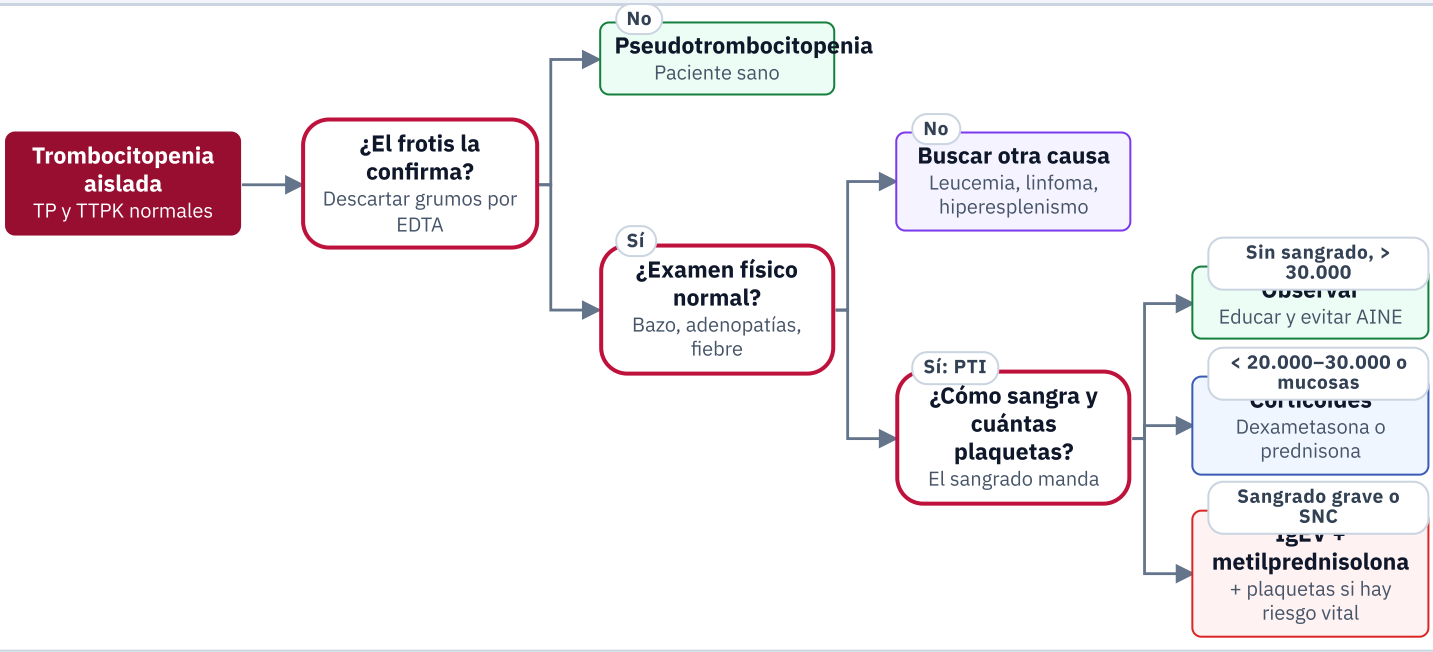
- **La PTI primaria es un diagnóstico de exclusión**: trombocitopenia aislada sin esplenomegalia ni adenopatías.
- Frotis obligatorio siempre para descartar Pseudotrombocitopenia por agregados plaquetarios inducidos por EDTA.
- En niños es aguda, autolimitada tras virosis y remite espontáneamente en > **80%**; en adultos es crónica y progresiva.
- Pacientes asintomáticos con plaquetas > 30.000/uL NO requieren corticoides ni hospitalización; solo observación.
- **Indicación de tratamiento**: plaquetas < 20.000-30.000/uL o presencia de hemorragias mucocutáneas activas.
- **Primera línea**: Dexametasona **40 mg**/día x **4 días** o Prednisona **1 mg/kg**/día x **2-4 semanas**.
- La Inmunoglobulina EV (IgEV **1 g**/kg) es la terapia de rescate urgente por su ascenso plaquetario rápido en **24-48 horas**.



PSEUDOTROMBOCITOPENIA
Atlas EUNACOM 2026

ALGORITMO · TROMBOCITOPENIA INMUNE: DEL HEMOGRAMA A LA CONDUCTA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **38, 41–43** (pág. 11) · solucionario págs. 29, 31.

Clase 8.12 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · HEMOSTASIA PRIMARIA, PLAQUETAS Y COAGULOPATÍAS

8.12 Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del Adulto y Niño: Criterios, Sangrado y Terapia GES

★★★ PRIORIDAD ALTA

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

TABLA 8.12 · COMPARACIÓN CLÍNICA Y TERAPÉUTICA: PTI PEDIÁTRICA VS PTI DEL ADULTO

CARACTERÍSTICA	PTI EN PEDIATRÍA (NIÑOS)	PTI EN ADULTOS
Edad Habitual de Presentación	Pico de incidencia entre 2 y 6 años de edad	Adultos jóvenes y medianos (18 a 40 años)
Predisposición por Sexo	Distribución igual entre niños y niñas (1:1)	Marcado predominio femenino (3:1 a 4:1)
Forma de Comienzo	Abrupta y explosiva (en horas o pocos días)	Insidiosa y progresiva (semanas a meses)
Antecedente Previo Gatillante	Presente en > 75% (infección viral respiratoria o exantema)	Habitualmente ausente (sin desencadenante reconocible)
Evolución Natural	Benigna y autolimitada: remisión espontánea en > 80%	Tendencia a la cronicidad en > 70-80% de los casos
Examen Físico Rector	Petequias y equimosis; Bazo NO palpable	Púrpura mucocutáneo; Bazo NO palpable
Conducta Terapéutica	Observación en la mayoría; tratar solo si sangrado mucoso	Tratar si plaquetas < 30.000 o sangrado: Corticoides/IgEV

TRAMPAS EUNACOM clase hem-12

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Trombocitopenia aislada en el hemograma	Frotis o repetir en citrato	Diagnosticar PTI sin frotis
Petequias + esplenomegalia o adenopatías	Buscar leucemia o linfoma	Llamarlo PTI
Niño post virosis, sin sangrado de mucosas	Observar: remite en > 80 %	Corticoides por el número

REGLA DE ORO **Primero el frotis** — Descartar pseudotrombocitopenia

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

La Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI, antes llamada idiopática) es el prototipo de trombocitopenia periférica por destrucción acelerada mediada por autoanticuerpos dirigidos contra las glicoproteínas plaquetarias IIb/IIIa e Ib/IX. El EUNACOM interroga de forma incisiva sus diferencias según edad: en niños suele ser aguda, autolimitada y precedida por una infección viral respiratoria o exantema; en adultos es de inicio insidioso, crónica y con predominio femenino. El diagnóstico es estrictamente de exclusión (médula ósea normal o con megacariocitos aumentados y sin esplenomegalia palpable). Saber cuándo tratar con corticoides e IgEV y cuándo observar es un objetivo docente crítico.

TABLA 8.12.B · ESCALAMIENTO FARMACOLÓGICO EN LA PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA INMUNE

LÍNEA TERAPÉUTICA	FÁRMACO / MODALIDAD	POSOLOGÍA ESTÁNDAR	MECANISMO DE ACCIÓN PRINCIPAL
Primera Línea (Oral)	Prednisona vía oral	1 mg/kg/día por 2 a 4 semanas con desescalamiento lento	Disminuye destrucción esplénica y síntesis de anticuerpos
Primera Línea (Pulsos)	Dexametasona oral / EV	40 mg/día por 4 días consecutivos (ciclos cada 14-28 días)	Respuesta rápida con menor duración de exposición a esteroides
Rescate de Urgencia	Inmunoglobulina EV (IgEV)	1 g/kg/día por 1 a 2 días (infusión hospitalaria monitorizada)	Bloqueo competitivo agudo de receptores Fc en macrófagos
Segunda Línea (AR-TPO)	Eltrombopag (VO) / Romiplostim (SC)	Eltrombopag 25-75 mg/día oral en ayunas	Estimulación directa del receptor c-Mpl en megacariocitos
Segunda Línea (Monoclonal)	Rituximab endovenoso	375 mg/m² semanal durante 4 semanas consecutivas	Lisis y depleción de linfocitos B productores de anti-GPIIb/IIIa
Segunda Línea (Cirugía)	Esplenectomía laparoscópica	Cirugía electiva diferida > 12 meses tras vacunación	Resección del órgano rector de fagocitosis plaquetaria

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **38, 41–43** (pág. 11) · solucionario págs. 29, 31.

Clase 8.12 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · HEMOSTASIA PRIMARIA, PLAQUETAS Y COAGULOPATÍAS TIER 3

8.13 Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand

Muy Alta · Herencia recesiva ligada al X, hemartrosis, TTPK prolongado aislado, tratamiento sustitutivo con factor liofilizado

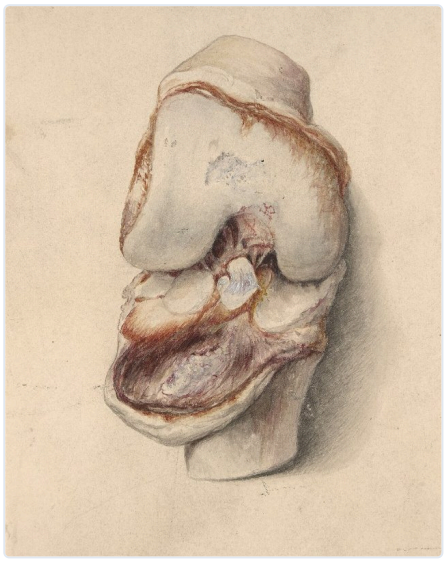
★★★ PRIORIDAD ALTA
10 preguntas reales 2013–2025

GES Garantía Explícita en Salud (GES N° 32): Hemofilia y otras coagulopatías congénitas

1.08.1.006	Coagulopatías congéni...	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar
1.08.2.003	Coagulopatía congénit...	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar
1.08.4.005	Estudio de coagulopatías	Interpreta y emplea		
2.01.1.036	Trastornos coagulación	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

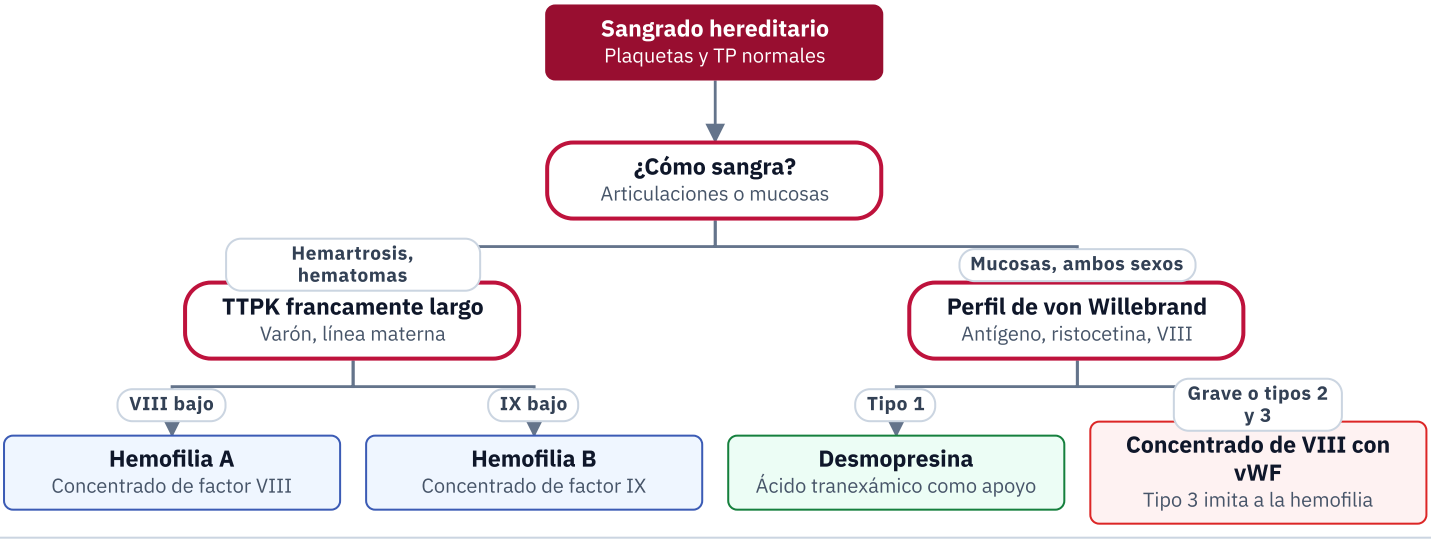
- **Hemofilia A (FVIII) y B (FIX)**: recesivas ligadas al cromosoma X (afectan a varones, transmitidas por mujeres).
- La hemartrosis recurrente en grandes articulaciones es la manifestación cardinal de la hemofilia severa.
- **Perfil hemostático de hemofilia**: plaquetas y TP normales, TTPK prolongado que corrige con plasma normal.
- Ante una hemartrosis se debe infundir el factor específico de inmediato; NUNCA realizar punción articular evacuadora.
- La Enfermedad de von Willebrand es autosómica dominante (afecta por igual a hombres y mujeres); sangrado mucocutáneo.
- Enfermedad de von Willebrand tipo 1 responde favorablemente a Desmopresina (DDAVP).
- **¡Contraindicaciones formales!**: NUNCA prescribir aspirina ni AINEs, ni realizar inyecciones intramusculares.



ARTROPATÍA HEMOFÍLICA
Wikimedia Commons «Knee joint of a haemophiliac Wellcome L0062595.jpg», CC BY 4.0, Godart, Thomas

ALGORITMO · COAGULOPATÍA CONGÉNITA: DE CÓMO SANGRA A QUÉ SE INFUNDE

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **44–49** (págs. 11–12) · solucionario págs. 31–33.

Clase 8.13 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · HEMOSTASIA PRIMARIA, PLAQUETAS Y COAGULOPATÍAS

8.13 Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand

★★★ PRIORIDAD ALTA

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

TABLA 8.13 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: HEMOFILIA A VS HEMOFILIA B VS ENFERMEDAD DE VON WILLEBRAND — = TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE HEM-13

CARACTERÍSTICA	HEMOFILIA A	HEMOFILIA B	ENFERMEDAD DE VON WILLEBRAND (TIPO 1)
Herencia Genética	Recesiva ligada al cromosoma X	Recesiva ligada al cromosoma X	Autosómica dominante (cromosoma 12)
Población Afectada	Varones exclusivamente (mujeres portadoras)	Varones exclusivamente (mujeres portadoras)	Ambos sexos por igual (hombres y mujeres)
Factor Deficiente	Factor VIII coagulante (F8)	Factor IX coagulante (F9)	Factor von Willebrand (vWF) cuantitativo
Manifestación Dominante	Hemartrosis articular y hematomas musculares	Hemartrosis articular y hematomas musculares	Sangrado mucocutáneo (epistaxis, menorragia)
Tiempo de Protrombina (TP)	Estrictamente NORMAL	Estrictamente NORMAL	Estrictamente NORMAL
TTPK / TTPA	Marcadamente PROLONGADO (corrige mezcla)	Marcadamente PROLONGADO (corrige mezcla)	Variable: prolongado o normal (según FVIII)
Tratamiento Farmacológico	Concentrado de Factor VIII liofilizado (GES 32)	Concentrado de Factor IX liofilizado (GES 32)	Desmopresina (DDAVP) / Concentrado FVIII-vWF

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA — clase hem-13

CARACTERÍSTICA	HEMOFILIA A Y B	VON WILLEBRAND TIPO 1
TP y plaquetas	Normales	Normales
Examen que confirma	Dosificar factores VIII y IX	Antígeno, ristocetina y VIII

REGLA DE ORO **Ligada al X, hemartrosis** — TTPK francamente largo

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

Las coagulopatías congénitas están cubiertas al 100% en Chile bajo el régimen GES N° 32 (Hemofilia). El EUNACOM evalúa: 1) La Hemofilia A (déficit de Factor VIII, 85% de los casos) y la Hemofilia B (déficit de Factor IX, 15%), transmitidas de forma recesiva ligada al cromosoma X, afectando clínicamente a varones con madres portadoras; 2) Las hemartrosis a repetición como manifestación distintiva que conduce a artropatía hemofílica invalidante; 3) La Enfermedad de von Willebrand como la diátesis hemorrágica hereditaria más común a nivel mundial (autosómica dominante con alteración de la hemostasia primaria y secundaria); y 4) La contraindicación formal de administrar aspirina, AINEs o realizar punciones articulares no cubiertas.

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **44–49** (págs. 11–12) · solucionario págs. 31–33.

Clase 8.13 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · HEMOSTASIA PRIMARIA, PLAQUETAS Y COAGULOPATÍAS

8.14 Coagulopatías Adquiridas: Hepatopatía Crónica, Déficit de Vitamina K y Manejo de Anticoagulantes

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
3 preguntas reales 2013–2025

1.08.1.005	Coagulopatías adquirid...	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar
1.08.2.002	Coagulopatía adquiri...	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Completo
1.08.3.012	Tratamiento anticoagulante	Conocimiento general		
1.08.3.006	Interacción de drogas y anticoagulant...	Conocimiento general		

LO QUE TE PREGUNTAN

- La vitamina K es necesaria para la carboxilación de los factores II, VII, IX y X, y de las proteínas C y S.
- El Factor V mide función sintética hepática directa y es independiente de vitamina K (diferencia daño hepático de déficit de vit K).
- **INR entre 4.5 y 10 sin sangrado**: suspender 1-2 dosis de acenocumarol; no requiere vitamina K de rutina.
- **INR > 10 sin sangrado**: suspender acenocumarol y administrar vitamina K1 oral a dosis bajas (**2.5 a 5 mg**).
- **Hemorragia grave con riesgo vital por cumarínicos**: Concentrado de Complejo Protrombínico (CCP) EV + Vitamina K **10 mg** EV.

ALGORITMO · CUMARÍNICO CON INR ALTO: QUÉ HACER

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

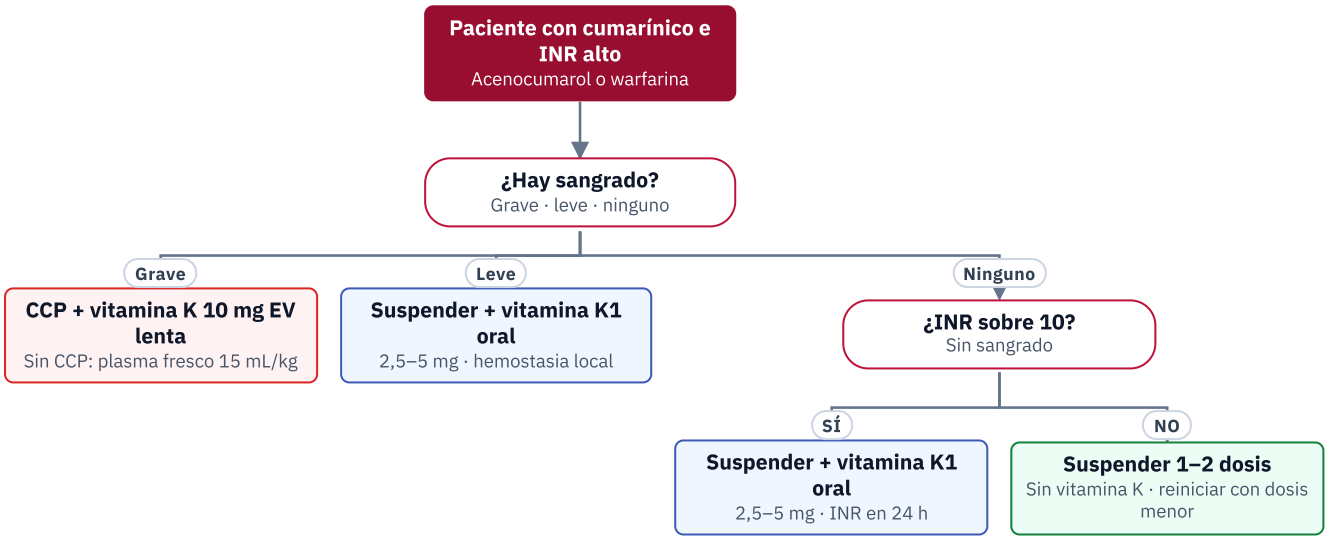


TABLA 8.14 · MANEJO ESCALONADO DE LA SOBREANTICOAGULACIÓN POR CUMARÍNICOS SEGÚN GUÍAS CLÍNICAS

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE HEM-14

NIVEL DE INR	MANIFESTACIÓN CLÍNICA	INTERVENCIÓN FARMACOLÓGICA RECOMENDADA	TIEMPO DE RESPUESTA
INR 4.5 a 10.0	Sin hemorragia activa	Suspender 1 a 2 dosis; NO administrar vitamina K de rutina	Descenso paulatino en 24 a 48 horas
INR > 10.0	Sin hemorragia activa	Suspender fármaco + Vitamina K1 oral 2.5 a 5 mg	Corrección de INR en 24 horas sin refractariedad
Cualquier INR	Hemorragia leve / mucocutánea	Suspender fármaco + Vitamina K1 oral 2.5 a 5 mg	Monitoreo y hemostasia local
Cualquier INR	Hemorragia grave o riesgo vital	Suspender + CCP 4 factores (25-50 UI/kg) EV + Vit K 10 mg EV	Reversión hemostática inmediata en 10-15 minutos (CCP)
Alternativa si no hay CCP	Hemorragia grave	Plasma Fresco Congelado (PFC 15 mL/kg) + Vitamina K 10 mg EV	Lenta (horas); riesgo de sobrecarga de volumen

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase hem-14

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
TP largo con factor V bajo	Daño hepático crónico	Esperar corrección con vitamina K
Colestasis o antibióticos prolongados	Déficit de vitamina K	Pensar en hemofilia
Hemorragia mayor con dabigatrán	Idarucizumab	Protamina

REGLA DE ORO **Vitamina K activa II, VII, IX y X** — Y las proteínas C y S

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **50–52** (págs. 12–13) · solucionario págs. 34–35.

Clase 8.14 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · HEMOSTASIA PRIMARIA, PLAQUETAS Y COAGULOPATÍAS

8.15 Coagulación Intravascular Diseminada (CID): Criterios ISTH, Sepsis/Obstetricia y Manejo

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

1.08.2.001 Coagulación intrav... Dx Sospecha Tx Inicial Seg No requiere

1.08.3.005 Indicaciones de uso de componentes ... Conocimiento general

LO QUE TE PREGUNTAN

- La CID es un síndrome adquirido de activación masiva de trombina que asocia microtrombosis con hemorragia por consumo.
- **Causas clásicas**: shock séptico (gramnegativos), emergencias obstétricas (abruptio) y politraumatismos graves.
- **Laboratorio clásico de CID**: plaquetas bajas + TP y TTPK prolongados + fibrinógeno colapsado (<100) + Dímero D altísimo.
- Score ISTH **≥ 5 puntos** confirma el diagnóstico de CID manifiesta descompensada.
- El tratamiento fundamental de la CID es tratar y erradicar la causa desencadenante de base.
- El hemoderivado de elección para corregir el fibrinógeno bajo (< **100-150 mg/dL**) es el Crioprecipitado.



PÚRPURA EN UNA SEPSIS
Manual CTO Infecciosas 14.ª ed., p. 38

ALGORITMO · SOSPECHA DE CID: DEL SCORE A LA CONDUCTA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

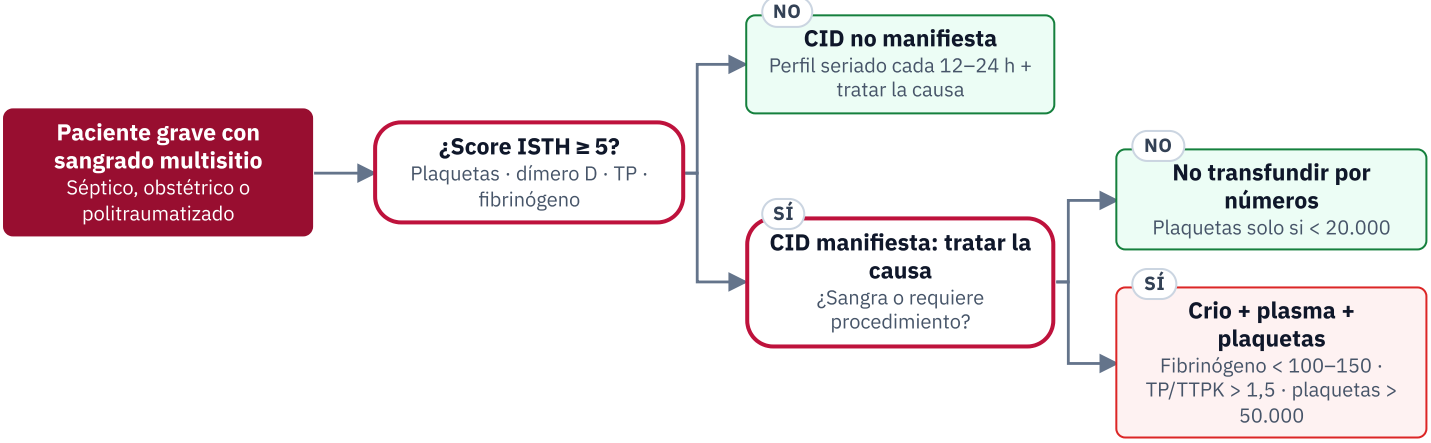


TABLA 8.15 · SCORE DIAGNÓSTICO DE CID MANIFIESTA DE LA ISTH (PUNTAJE ≥ 5 CONFIRMA CID)

PARÁMETRO ANALÍTICO EVALUADO	PUNTAJE ASIGNADO (SCORE ISTH)	SIGNIFICADO EN LA FISIOPATOLOGÍA
Recuento de Plaquetas	> 100.000: 0 pts | 50.000-100.000: 1 pt | < 50.000: 2 pts	Grado de consumo plaquetario periférico en microtrombos
Dímero D / PDF	Normal: 0 pts | Elevación moderada: 2 pts | Elevación severa: 3 pts	Intensidad de la fibrinólisis reactiva por plasmina
Tiempo de Protrombina (TP)	Prolongación < 3 seg: 0 pts | 3 a 6 seg: 1 pt | > 6 seg: 2 pts	Consumo de factores de coagulación de vía extrínseca/común
Concentración de Fibrinógeno	> 100 mg/dL: 0 pts | < 100 mg/dL: 1 pt	Agotamiento del sustrato final para la formación de fibrina
Puntaje Total ISTH	≥ 5 Puntos = CID Manifiesta compatible	Indica necesidad de soporte transfusional y monitorización

TRAMPAS EUNACOM

clase hem-15

CUADRO	LABORATORIO	CLAVE
CID	Plaquetas bajas + TP y TTPK largos + fibrinógeno bajo + dímero D alto	Todo alterado a la vez
PTI	Solo plaquetas bajas	Coagulación normal
PTT y SHU	Plaquetas bajas + esquistocitos	TP y TTPK normales

REGLA DE ORO **Síndrome secundario** — Sepsis, obstetricia, trauma, M3

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **53–54** (pág. 13) · solucionario pág. 35.

Clase 8.15 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ONCOHEMATOLOGÍA: NEOPLASIAS MIELOIDES Y LINFOIDES TIER 3

8.16 Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante

★★★ PRIORIDAD ALTA
11 preguntas reales 2013–2025

GES Garantía Explícita en Salud (GES N° 37 y N° 8): Leucemias en personas de 15 años y más / Menores de 15 años

Máxima · Presencia de blastos en sangre periférica, punción medular urgente, subtipo M3 con promielocitos y CID

1.08.1.009	Leucemias agudas	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar	1.08.4.009	Mielograma	Emplea informe
2.01.1.032	Leucemias	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar	1.08.5.005	Mielograma	Derivar a especialista
1.08.5.008	Quimioterapia intratecal	Derivar a especialista			

LO QUE TE PREGUNTAN

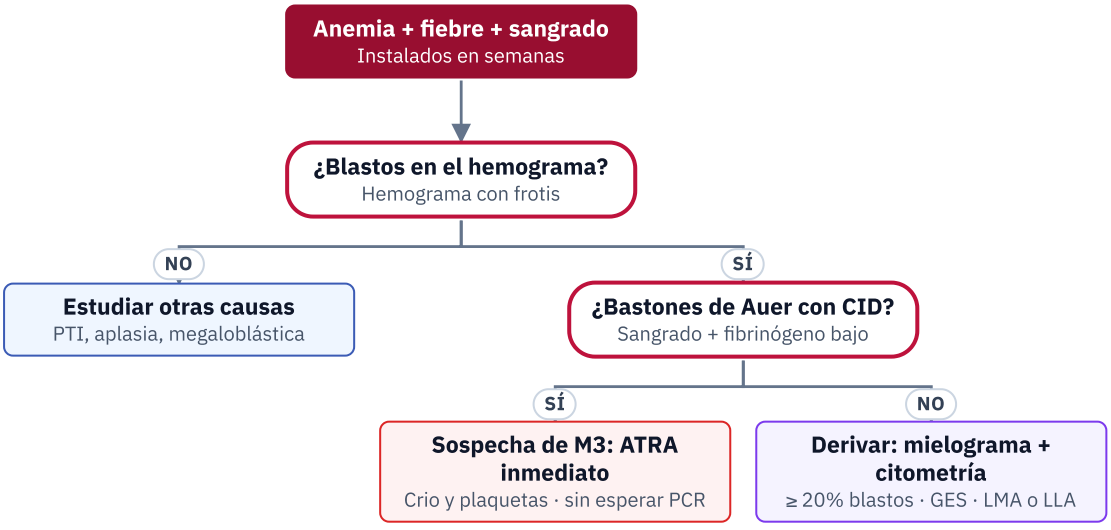
- **Criterio rector de leucemia aguda según la OMS**: presencia de **≥ 20%** de blastos en médula ósea o sangre.
- Los Bastones de Auer son patognomónicos de Leucemia Mieloide Aguda (LMA) y jamás se observan en LLA.
- La LMA es la leucemia aguda del adulto; la LLA es la neoplasia maligna más común en pediatría (>**85%** curación).
- La Leucemia Promielocítica Aguda (LMA-M3) cursa con t(15;17) y CID catastrófica que requiere ATRA urgente.
- La LLA invade precozmente santuarios anatómicos (meninges y testículos), requiriendo quimioterapia intratecal profiláctica.
- La presencia de blastos en sangre periférica exige mielograma y biopsia osteomedular urgente en centro terciario.
- El tratamiento definitivo curativo en LMA de riesgo intermedio o adverso es el Trasplante Alogénico de Médula Ósea.



INFILTRACIÓN GINGIVAL
Manual CTO Hematología 14.ª ed., p. 63

ALGORITMO · LEUCEMIA AGUDA: DE LA SOSPECHA A LA CONDUCTA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **55–59** (págs. 13–14) · solucionario págs. 35–36.

Clase 8.16 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ONCOHEMATOLOGÍA: NEOPLASIAS MIELOIDES Y LINFOIDES

8.16 Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante

★★★ PRIORIDAD ALTA

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

TABLA 8.16 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CLÍNICO Y BIOLÓGICO: LMA VS LLA — = TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE HEM-16

CARACTERÍSTICA	LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA (LMA)	LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA (LLA)
Población Predominante	Adultos mayores (mediana 68 años); 20% en niños	Pediátrica (pico 2 a 5 años); 20% en adultos
Morfología de Blastos	Células grandes, citoplasma amplio, gránulos azurófilos	Células medianas, citoplasma escaso, sin gránulos
Bastones de Auer	PRESENTES (Patognomónicos de LMA)	AUSENTES en el 100% de los casos
Citoquímica Enzimática	Mieloperoxidasa (MPO) POSITIVA, Sudán Negro (+)	MPO NEGATIVA; TdT POSITIVA en >95%
Inmunofenotipo Citometría	CD13 (+), CD33 (+), CD117 (+), MPO (+)	Estirpe B: CD19, CD10, CD22 | Estirpe T: CD3, CD7
Infiltración Tisular Clásica	Hiperplasia gingival, cloromas cutáneos (M4/M5)	Sistema nervioso central (meninges) y testículos
Emergencia Específica	LMA-M3: CID catastrófica -> Tratar con ATRA urgente	Síndrome de lisis tumoral agudo al iniciar quimio
Pronóstico Curativo Global	30% a 40% de sobrevida en adultos; peor en ancianos	> 85% a 90% de curación en niños (GES N° 8)

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA — clase hem-16

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Anemia + fiebre + sangrado en semanas	Hemograma con frotis	Pensar solo en infección
Blastos en sangre periférica	Derivación urgente + mielograma	Controlar en unas semanas
Confirmación diagnóstica	Mielograma: ≥ 20% de blastos	Quedarse solo con el hemograma

REGLA DE ORO — **Anemia + fiebre + sangrado en semanas** — Insuficiencia medular aguda

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

Las leucemias agudas representan una proliferación clonal descontrolada y maligna de células progenitoras hematopoyéticas inmaduras (blastos) que invaden la médula ósea, desplazando a la hematopoyesis normal y diseminándose a sangre y tejidos. El EUNACOM interroga: 1) La clínica de insuficiencia medular aguda (anemia severa, neutropenia con infecciones graves y trombocitopenia purpúrica); 2) El punto de corte rector de la OMS: ≥ 20% de blastos en médula ósea o sangre periférica; 3) La presencia de Bastones de Auer como patognomónica de LMA; 4) La Leucemia Promielocítica Aguda (LMA-M3) con translocación t(15;17) y su emergencia hemorrágica por CID que requiere Ácido Todo-Trans-Retinoico (ATRA) de inmediato; y 5) La LLA como la neoplasia más común de la infancia, cubierta por GES.

TABLA 8.16.B · FASES TERAPÉUTICAS DE LAS LEUCEMIAS AGUDAS EN PROTOCOLOS GES NACIONALES

FASE DEL TRATAMIENTO	ESQUEMA Y MEDICAMENTOS	OBJETIVO PRIMARIO	CONSIDERACIÓN DE MANEJO
Fase de Inducción LMA	Esquema "7+3": Citarabina EV x 7 d + Daunorrubicina EV x 3 d	Destruir > 99% de blastos y lograr Remisión Completa	Aplasia profunda de 3 a 4 semanas; requiere soporte intensivo
Inducción LMA-M3	ATRA (Ácido todo-trans-retinoico) oral + Trióxido de arsénico	Diferenciación de promielocitos y cese de la CID	Vigilar Síndrome de Diferenciación (tratar con Dexametasona)
Inducción LLA Infantil	Vincristina + Dexametasona + L-asparaginasa + Daunorrubicina	Erradicación de blastos linfoides medulares	Manejo protocolizado PINDA GES N° 8
Profilaxis de SNC en LLA	Punciones lumbares con triple quimioterapia intratecal	Esterilizar el santuario meníngeo para evitar recidivas	Metotrexato + Citarabina + Dexametasona intratecal
Terapia de Consolidación	Trasplante Alogénico de Médula Ósea (Alo-TPH)	Efecto injerto contra leucemia curativo definitivo	En pacientes con riesgo intermedio/alto y donante HLA

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **55–59** (págs. 13–14) · solucionario págs. 35–36.

Clase 8.16 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ONCOHEMATOLOGÍA: NEOPLASIAS MIELOIDES Y LINFOIDES

8.17 Leucemias Crónicas: Leucemia Mieloide Crónica (LMC, BCR-ABL) vs Leucemia Linfática Crónica (LLC)

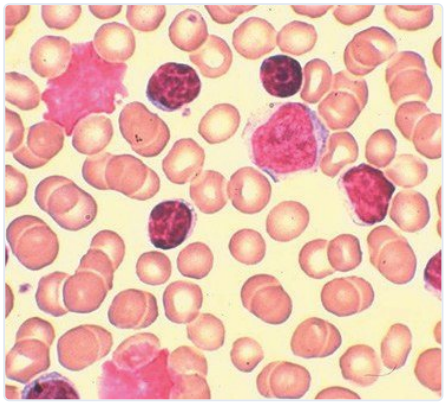
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
4 preguntas reales 2013–2025

GES Garantía Explícita en Salud (GES N° 37): Leucemia en personas de 15 años y más (LMC)

1.08.1.010	Leucemias crónicas	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar
1.08.1.014	Reacción leucemoide	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- La LMC se asocia en el **95%** al Cromosoma Filadelfia t(9;22), que genera el oncogén de fusión BCR-ABL1.
- **Frotis de LMC**: toda la serie granulocítica (mielocitos, metamielocitos) con basofilia y eosinofilia característica.
- El tratamiento de elección en LMC son los Inhibidores de Tirosina Quinasa orales (Imatinib), garantizados en GES N° 37.
- La LLC es la leucemia más común del adulto mayor; se caracteriza por linfocitosis B madura clonal (CD19+/CD5+).
- Las Sombras de Gümprecht (manchas de lisis nuclear por fragilidad en frotis) son patognomónicas de la LLC.



SOMBRAS DE GÜMPRECHT
Goljan, Rapid Review Pathology, Link 13-19

ALGORITMO · LEUCEMIAS CRÓNICAS: DEL HEMOGRAMA A LA CONDUCTA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

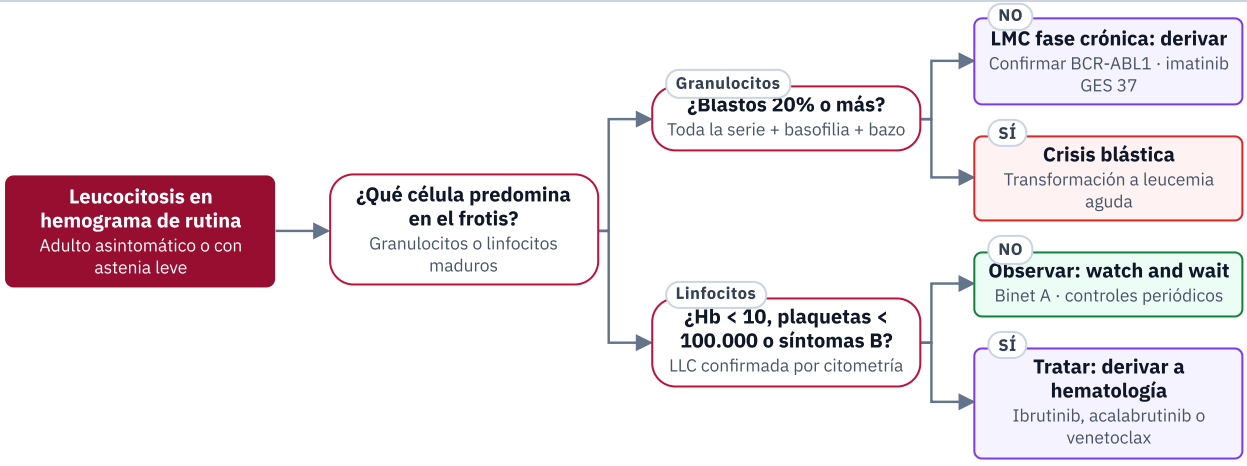


TABLA 8.17 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA (LMC) VS LEUCEMIA LINFÁTICA CRÓNICA (LLC)

PARÁMETRO	LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA (LMC)	LEUCEMIA LINFÁTICA CRÓNICA (LLC)
Población Típica	Adultos de 40 a 60 años	Adultos mayores y ancianos (> 70 años)
Serie Proliferante	Mieloide granulocítica completa (con basofilia)	Linfoide B madura monótona (CD19+, CD5+)
Frotis Sanguíneo	Mielocitos, metamielocitos, bandas, segmentados	Linfocitos maduros + Sombras de Gümprecht
Genética Marcadora	Cromosoma Filadelfia t(9;22) / Oncogén BCR-ABL1	Deleción 13q (buen pronóstico), del 17p / TP53 (mal pronóstico)
Signo Semiológico Clave	Esplenomegalia gigante indolora frecuente	Adenopatías generalizadas bilaterales e indoloras
Riesgo de Transformación	Crisis Blástica (transformación a leucemia aguda)	Síndrome de Richter (transformación a linfoma difuso agresivo)
Conducta Inicial Estándar	Tratamiento inmediato con Imatinib (ITK) oral	Observación expectante ("Watch and Wait") en Binet A

TRAMPAS EUNACOM

clase hem-17

ESCENARIO	RESPUESTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Leucocitosis, toda la serie, basofilia, bazo grande	LMC	Llamarla leucemia aguda por ver algún blasto
LMC confirmada	ITK oral: imatinib (GES 37)	Quimioterapia clásica
Anciano con linfocitosis y Gümprecht	LLC	Linfoma o LMC

REGLA DE ORO **Toda la serie + basofilia + bazo gigante** — Plaquetas normales o altas

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **60–62** (pág. 14) · solucionario pág. 37.

Clase 8.17 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ONCOHEMATOLOGÍA: NEOPLASIAS MIELOIDES Y LINFOIDES TIER 3

8.18 Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular)

★★★ PRIORIDAD ALTA
7 preguntas reales 2013–2025

Muy Alta · Biopsia escisional ganglionar obligatoria, estadios Ann Arbor, Síntomas B y esquema ABVD/R-CHOP

GES Garantía Explícita en Salud (GES N° 38 y N° 8): Linfomas en personas de 15 años y más / Menores de 15 años

1.08.1.011	Linfomas	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar	1.08.5.002	Biopsia ganglionar — Derivar a especialista
2.01.1.033	Linfomas	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar	1.08.4.001	Radiografía de tórax — Interpreta y emplea
6.01.1.014	Linfomas cutáneos	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar		

LO QUE TE PREGUNTAN

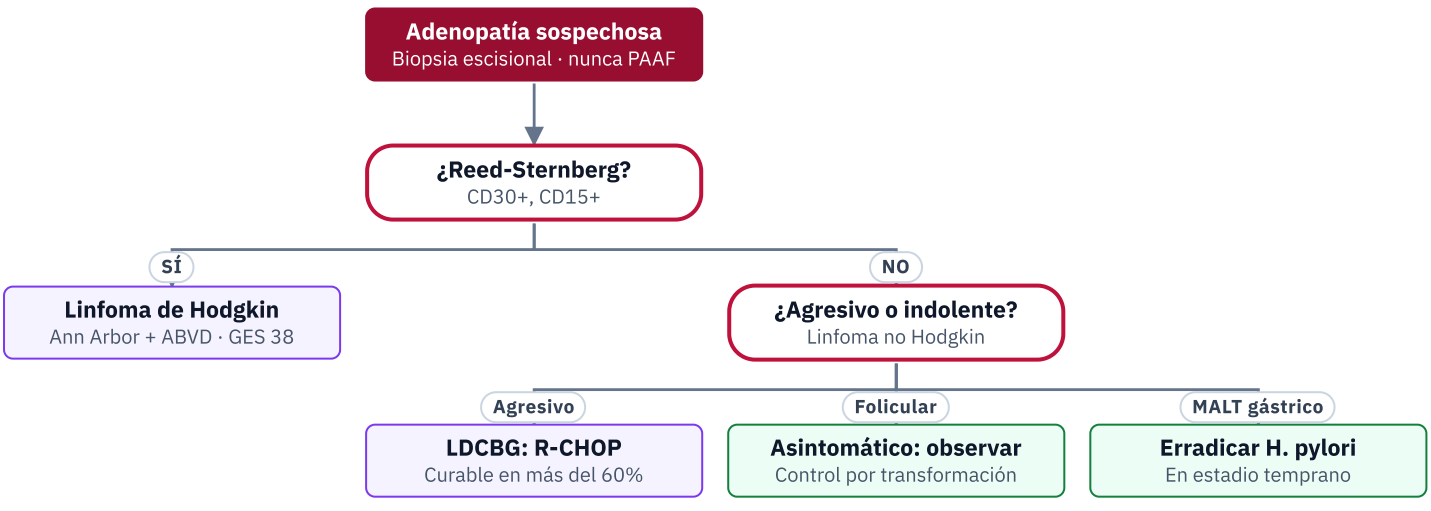
- **Regla de oro**: el diagnóstico de linfoma exige Biopsia Escisional de Ganglio Linfático COMPLETO (la PAAF no sirve).
- **Síntomas B**: fiebre inexplicada > **38 °C**, sudoración nocturna profusa y baja de peso involuntaria > **10%** en **6 meses**.
- El Linfoma de Hodgkin presenta distribución bimodal (20-30 a y >60 a) y células binucleadas de Reed-Sternberg (CD30+/CD15+).
- El subtipo más común de Hodgkin es la Esclerosis Nodular (**70%**, mujeres jóvenes, masa mediastínica).
- **Diseminación de Hodgkin**: contigua y ordenada por estaciones linfáticas; diseminación de No Hodgkin: hematógena precoz.
- El Linfoma No Hodgkin más común es el Difuso de Células B Grandes (LDCBG), agresivo pero potencialmente curable con R-CHOP.
- El Linfoma Folicular t(14;18) BCL-2 es indolente e incurable con quimioterapia estándar; se observa si está asintomático.



ADENOPATÍA SUPRACLAVICULAR
Knoop, Atlas of Emergency Medicine, p. 193

ALGORITMO · ADENOPATÍA SOSPECHOSA: DEL GANGLIO AL TRATAMIENTO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **63–65** (pág. 14) · solucionario pág. 38.

Clase 8.18 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ONCOHEMATOLOGÍA: NEOPLASIAS MIELOIDES Y LINFOIDES

8.18 Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular)

★★★ PRIORIDAD ALTA

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

TABLA 8.18 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: LINFOMA DE HODGKIN VS LINFOMAS NO HODGKIN

CARACTERÍSTICA	LINFOMA DE HODGKIN (LH)	LINFOMAS NO HODGKIN (LNH)
Distribución por Edades	Bimodal (picos a los 20-30 años y > 60 años)	Incidencia continuamente creciente con la edad (> 60 a)
Patrón de Diseminación	Ordenado, por contigüidad linfática anatómica	No contiguo, desordenado, diseminación hematógena precoz
Compromiso Extraganglionar	Muy raro en fases iniciales (< 5-10%)	Muy frecuente (> 30-40%: digestivo, SNC, piel, bazo)
Compromiso Mediastínico	Muy frecuente en subtipo Esclerosis Nodular (60%)	Menos común (salvo linfoma mediastínico primario B)
Célula Neoplásica Típica	Célula gigante de Reed-Sternberg (CD30+, CD15+)	Proliferación clonal homogénea de linfocitos B o T
Infiltrado Inflamatorio	Predominante (98% de la masa tumoral es reactiva)	Escaso (la masa está formada por células neoplásicas)
Curabilidad Global	Altamente curable (> 85% de curación con ABVD)	Curable en agresivos (LDCBG 60%); incurable en foliculares

TRAMPAS EUNACOM clase hem-18

ESCENARIO	RESPUESTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Adenopatía sospechosa de linfoma	Biopsia escisional del ganglio	PAAF
Joven con adenopatía y síntomas B	Linfoma, probable Hodgkin	Tuberculosis o mononucleosis
Definir síntomas B	Fiebre, sudoración, baja de peso > 10%	Incluir prurito o dolor con alcohol

REGLA DE ORO **Indolora, gomosa, > 2 cm, > 4–6 semanas** — Sospechar linfoma

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

Los linfomas son neoplasias malignas que se originan en el sistema linfoide (ganglios linfáticos, bazo, timo y tejido linfoide asociado a mucosas). El EUNACOM evalúa con extrema rigurosidad: 1) La regla de oro diagnóstica: LA BIOPSIA ESCISIONAL DEL GANGLIO ENTERO ES OBLIGATORIA (la punción aspirativa con aguja fina [PAAF] es insuficiente e inválida para clasificar linfomas porque destruye la arquitectura tisular); 2) La definición estricta de los Síntomas B constitucionales (fiebre > 38 °C, sudoración nocturna profusa y baja de peso > 10% en 6 meses); 3) El Linfoma de Hodgkin (células gigantes binucleadas de Reed-Sternberg con aspecto en "ojos de búho", diseminación por contigüidad y alta curabilidad con quimioterapia ABVD); y 4) Los Linfomas No Hodgkin (LNH difuso de células B grandes agresivo curable con R-CHOP vs linfoma folicular indolente). Cubiertos al 100% por GES N° 38.

TABLA 8.18.B · ESQUEMAS DE QUIMIOTERAPIA GARANTIZADOS EN GES N° 38

PATOLOGÍA LINFOIDE	RÉGIMEN FARMACOLÓGICO DE ELECCIÓN	FÁRMACOS INTEGRANTES	TOXICIDAD CLAVE A MONITORIZAR
Linfoma de Hodgkin Clásico	Esquema ABVD	Doxorrubicina + Bleomicina + Vinblastina + Dacarbazina	Bleomicina: Toxicidad pulmonar fibrótica | Doxorrubicina: Cardiotoxicidad
LNH Difuso Células B Grandes	Inmunoquimioterapia R-CHOP	Rituximab + Ciclofosfamida + Doxorrubicina + Vincristina + Prednisona	Vincristina: Neuropatía periférica axonal | Rituximab: Infusión/Reactivación VHB
Linfoma Folicular Asintomático	Conducta expectante ("Watch and Wait")	Sin fármacos hasta progresión sintomática	Monitoreo clínico semestral para detectar transformación a LDCBG
Linfoma Gástrico MALT temprano	Terapia erradicadora de Helicobacter pylori	Inhibidor bomba protones + Claritromicina + Amoxicilina	Erradicación de H. pylori cura el linfoma MALT en >75% de casos

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **63–65** (pág. 14) · solucionario pág. 38.

Clase 8.18 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ONCOHEMATOLOGÍA: NEOPLASIAS MIELOIDES Y LINFOIDES

8.19 Mieloma Múltiple: Criterios CRAB, Pico Monoclonal, Gammapatía Monoclonal Incierta (GMSI)

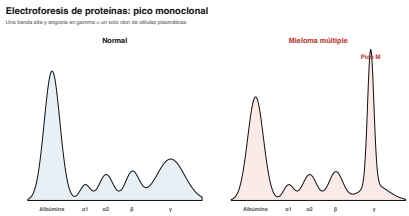
★★☆ **PRIORIDAD MEDIA**
3 preguntas reales 2013–2025

GES Garantía Explícita en Salud (GES N° 72): Mieloma Múltiple en personas de 15 años y más

1.08.1.007	Disproteinemias (gam...	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar	
1.08.4.004	Electroforesis de proteínas				Emplea informe

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Nemotecnia CRAB**: Calcio alto (>11), Renal (creatinina >2), Anemia (Hb <10), Bone (lesiones líticas en sacabocado).
- VHS > **100 mm**/h con fenómeno de Rouleaux (pilas de monedas en frotis) es altamente sugestiva de mieloma múltiple.
- La Electroforesis de Proteínas demuestra un pico monoclonal estrecho en región gamma (IgG **55%**, IgA **20%**).
- El "Riñón de Mieloma" se debe a la precipitación y obstrucción intratubular por cilindros de cadenas ligeras libres.
- **GMSI**: pico M < **3 g/dL**, plasmocitos medulares < **10%** y AUSENCIA de criterios CRAB (se observa anualmente).



ELECTROFORESIS CON PICO M
Dibujo propio (esquema)

ALGORITMO · MIELOMA MÚLTIPLE: DEL PICO MONOCLONAL A LA CONDUCTA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

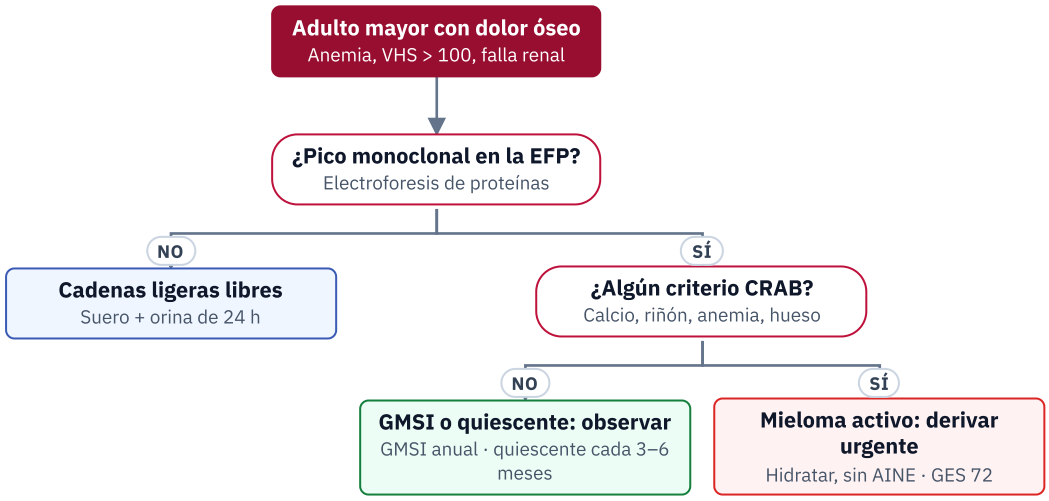


TABLA 8.19 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: MIELOMA MÚLTIPLE VS GMSI VS MIELOMA QUIESCENTE (SMOLDERING)

CRITERIO DIAGNÓSTICO	GAMMAPATÍA MONOCLONAL INCIERTA (GMSI)	MIELOMA QUIESCENTE (ASINTOMÁTICO)	MIELOMA MÚLTIPLE ACTIVO (SINTOMÁTICO)
Componente M Sérico	< 3.0 g/dL	≥ 3.0 g/dL (o en orina ≥ 500 mg/24h)	Presente (cualquier nivel; habitualmente > 3 g/dL)
Plasmocitos en Médula Ósea	< 10% del total celular nucleado	10% a 59% de celularidad plasmática	≥ 10% (o plasmocitoma extramedular probado)
Criterios de Daño CRAB	RIGUROSAMENTE AUSENTES	RIGUROSAMENTE AUSENTES	AL MENOS 1 CRITERIO CRAB PRESENTE
Conducta Terapéutica	Observación ambulatoria anual; no tratar	Monitoreo estrecho cada 3-6 meses; no quimio	Tratamiento inmediato: Bortezomib + Lenalidomida + Dexa

TRAMPAS EUNACOM

clase hem-19

ESCENARIO	RESPUESTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Adulto mayor: dolor óseo + anemia + falla renal + VHS > 100	Mieloma múltiple	Cáncer de próstata o renal metastásico
Pico M < 3 g/dL, plasmocitos < 10%, sin CRAB	GMSI: observar anualmente	Quimioterapia
Pico M con 1 criterio CRAB	Mieloma activo: tratar ya	Esperar y controlar

REGLA DE ORO **Calcio > 11 · creatinina > 2** — Hb < 10 · lesiones en sacabocado

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **66–69** (págs. 14–15) · solucionario pág. 39.

Clase 8.19 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ONCOHEMATOLOGÍA: NEOPLASIAS MIELOIDES Y LINFOIDES

8.20 Neoplasias Mieloproliferativas (Policitemia Vera JAK2, TE, Mielofibrosis) y Mielodisplasia

PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

1.08.1.018 Síndromes mieloprolife... Dx Sospecha Tx Inicial Seg Derivar

1.08.1.017 Síndromes mielodisplá... Dx Sospecha Tx Inicial Seg Derivar

1.08.1.015 Síndrome leucoeritrobl... Dx Sospecha Tx Inicial Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- La Policitemia Vera presenta eritrocitosis con mutación del gen JAK2 V617F en >**95%** y EPO sérica suprimida.
- **Tríada clínica de PV**: rubicundez facial, esplenomegalia palpable y prurito acuagénico tras ducha caliente.
- **Meta terapéutica fundamental en Policitemia Vera**: Hematocrito estrictamente < **45%** mediante flebotomías.
- Las poliglobulias secundarias cursan con EPO sérica elevada y JAK2 negativo (EPOC, apnea del sueño, fumador).
- **Mielofibrosis Primaria**: esplenomegalia gigante + dacriocitos (células en lágrima) en frotis + punción medular seca.

ALGORITMO · NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS: QUÉ SERIE ESTÁ ALTERADA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

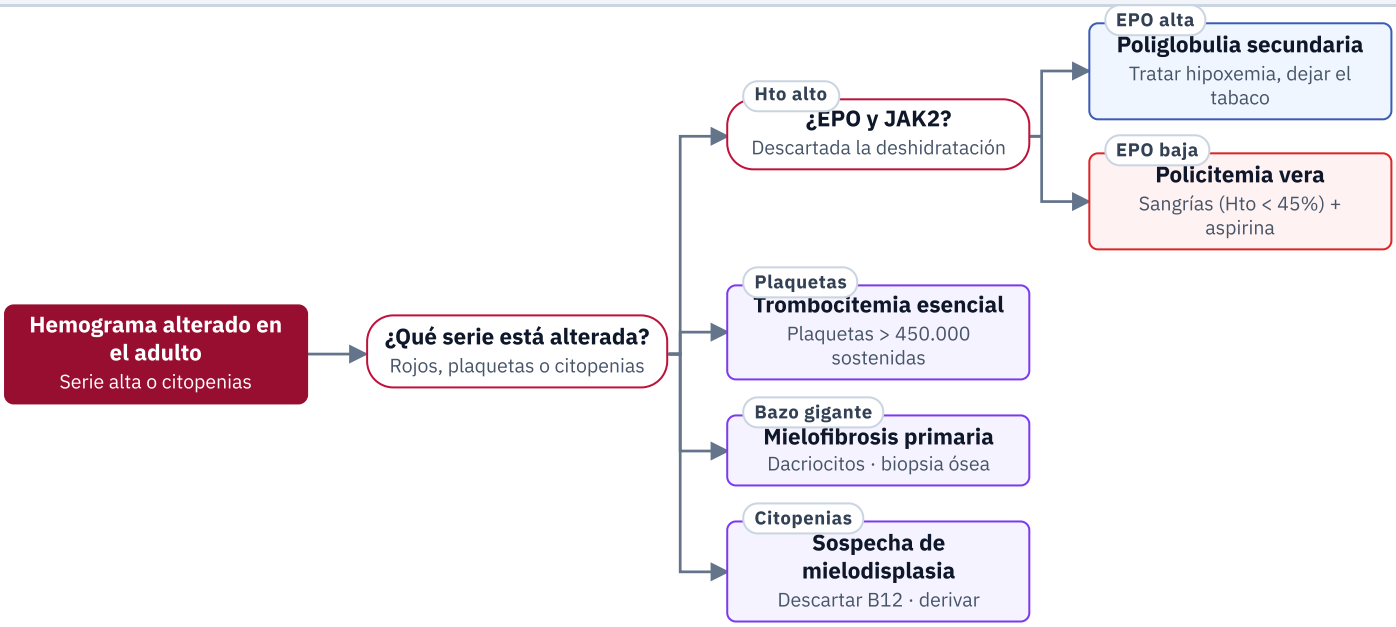


TABLA 8.20 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: POLICITEMIA VERA VS POLIGLOBULIAS SECUNDARIAS

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE HEM-20

CARACTERÍSTICA	POLICITEMIA VERA (NEOPLASIA PRIMARIA)	POLIGLOBULIA SECUNDARIA (HIPÓXICA O TUMORAL)
Mecanismo Patogénico	Proliferación clonal autónoma medular (JAK2)	Estimulación fisiológica o patológica por Eritropoyetina
Mutación JAK2 V617F	PRESENTE en > 95% a 98% de los casos	RIGUROSAMENTE NEGATIVA (0%)
Niveles de Eritropoyetina (EPO)	SUPRIMIDOS o Indetectables (< 2-4 mIU/mL)	ELEVADOS (> 20-100 mIU/mL)
Otras Series en Hemograma	Panmielosis: Leucocitosis y Trombocitosis asociadas	Glóbulos blancos y plaquetas normales
Esplenomegalia	Presente en > 70% de los pacientes	Ausente
Prurito Acuagénico	Muy característico (desencadenado por agua tibia)	Ausente
Etiologías Típicas	Neoplasia clonal hematopoyética primaria	EPOC severo, apnea del sueño, tabaquismo, carcinoma renal

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase hem-20

ESCENARIO	RESPUESTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Fumador o EPOC con Hto alto	EPO alta, JAK2 negativo: tratar la causa	Flebotomías de entrada
PV de bajo riesgo	Sangrías (Hto < 45%) + aspirina	Quimioterapia o anticoagulación oral

REGLA DE ORO **Prurito tras ducha caliente + bazo** — Facies pletórica y panmielosis

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **70–72** (pág. 15) · solucionario págs. 39–40.

Clase 8.20 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · URGENCIAS ONCOHEMATOLÓGICAS, TROMBOFILIAS Y MEDICINA TRANSFUSIONAL TIER 3

8.21 Neutropenia Febril en Oncología: Estratificación MASCC, Monoterapia Antipseudomónica y Urgencia Médica

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
4 preguntas reales 2013–2025

GES Garantía Explícita en Salud: Urgencia Vital en Paciente Oncológico GES

1.08.2.006 Neutropenia febril — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

1.04.1.020 Neutropenia febril — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Neutropenia**: RAN < 500/uL (o < 1.000 con caída prevista); Fiebre: T° **≥ 38.3** °C única o **≥ 38.0** °C x **1 hora**.
- La "Hora de Oro" exige administrar el antibiótico endovenoso en menos de **60 minutos** desde la llegada al hospital.
- El tacto rectal y los termómetros rectales están ESTRICTAMENTE CONTRAINDICADOS en el paciente neutropénico.
- El tratamiento de elección en neutropenia febril de alto riesgo (MASCC < 21) es monoterapia con Cefepime o Pip/Tazo EV.
- La vancomicina NO se indica de rutina; se reserva para shock séptico, sospecha de infección de CVC o mucositis grave.
- El paciente con score MASCC **≥ 21** (bajo riesgo) puede tratarse ambulatoriamente con ciprofloxacino + amoxicilina/clavulánico.

ALGORITMO · NEUTROPENIA FEBRIL: DE LA FIEBRE AL ANTIBIÓTICO

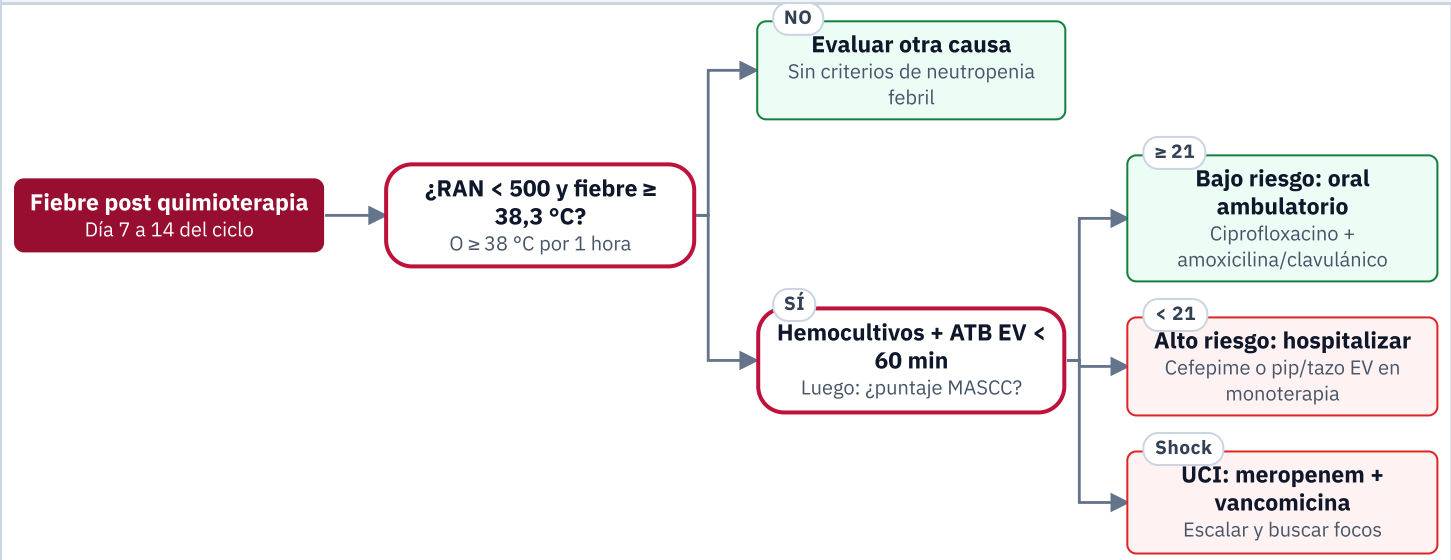


TABLA 8.21 · ESTRATIFICACIÓN Y MANEJO DE LA NEUTROPENIA FEBRIL SEGÚN SCORE MASCC

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE HEM-21

CATEGORÍA DE RIESGO	PUNTAJE MASCC	LUGAR DE ATENCIÓN	ESQUEMA ANTIBIÓTICO INICIAL DE ELECCIÓN
Bajo Riesgo	≥ 21 Puntos (sin factores de alarma)	Manejo ambulatorio con recontrol estrecho en 24 h	Ciprofloxacino 500-750 mg c/12h VO + Amoxicilina/Clavulánico 875 mg c/8h VO
Alto Riesgo	< 21 Puntos (o neutropenia prolongada)	Hospitalización obligatoria en aislamiento protector / UPC	Monoterapia EV: Cefepime 2 g c/8h EV O Piperacilina/Tazobactam 4.5 g c/6h EV
Alto Riesgo + Shock	< 21 Puntos con inestabilidad hemodinámica	Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)	Meropenem 1 g c/8h EV + Vancomicina 15-20 mg/kg c/12h EV + Amikacina
Infección Catéter CVC	Cualquier score con eritema en túnel	Hospitalización en sala / aislamiento	Cefepime o Pip/Tazo + Vancomicina EV; evaluar retiro del catéter si túnel infectado

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase hem-21

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Fiebre 10 días post quimioterapia	Hemograma con RAN, urgente	Antipiréticos y control
Neutropenia febril sin foco aparente	Antibiótico EV en < 60 min	Esperar radiografía o cultivos
Examen físico del neutropénico	Inspeccionar zona perianal	Tacto rectal o termómetro rectal

REGLA DE ORO **RAN < 500 + fiebre ≥ 38,3 °C** — O ≥ 38 °C sostenida por 1 hora

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **73–75** (págs. 15–16) · solucionario págs. 40–41.

Clase 8.21 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · URGENCIAS ONCOHEMATOLÓGICAS, TROMBOFILIAS Y MEDICINA TRANSFUSIONAL

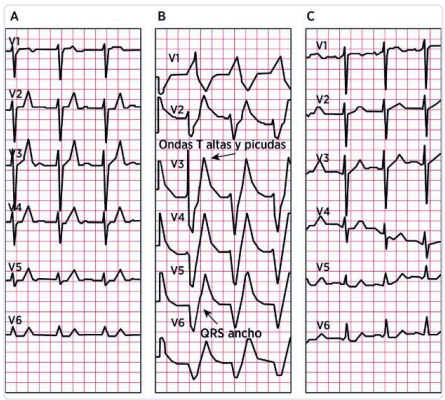
8.22 Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular

★★★ PRIORIDAD ALTA
6 preguntas reales 2013–2025

1.08.2.005	Lisis tumoral aguda	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg No requiere
1.08.2.004	Hipercalcemia	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar
1.08.2.007	Síndrome de compresi...	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar
1.10.2.011	Paraplejia aguda	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg No requiere

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Criterios Cairo-Bishop**: hiperuricemia (**≥8**), hiperkalemia (**≥6**), hiperfosfemia (**≥4.5**) e hipocalcemia (**≤7**).
- La profilaxis de elección en alto riesgo (Burkitt/leucemias) es la hidratación agresiva más Rasburicasa (urato oxidasa).
- La Rasburicasa convierte el ácido úrico en alantoína hidrosoluble; contraindicada en pacientes con déficit de G6PD.
- El alopurinol bloquea la síntesis de nuevo ácido úrico pero no degrada el ya formado; útil en riesgo bajo a intermedio.
- La hipercalcemia maligna se trata con hidratación endovenosa abundante con solución salina seguida de Ácido Zoledrónico EV.



ECG DE HIPERKALEMIA
Manual CTO Nefrología 14.ª ed., p. 23

ALGORITMO · URGENCIAS ONCOLÓGICAS: EL PRIMER PASO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

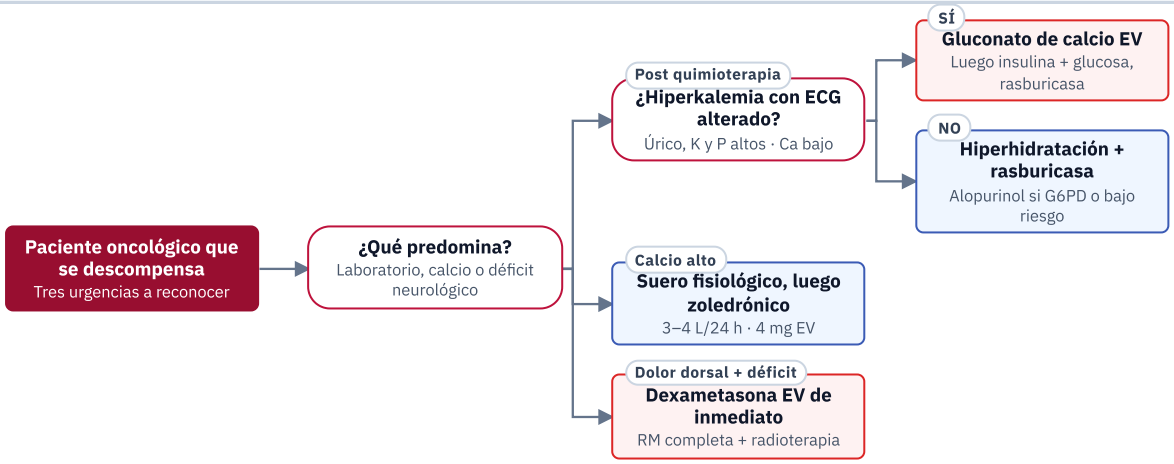


TABLA 8.22 · CRITERIOS DE LABORATORIO DE CAIRO-BISHOP PARA SÍNDROME DE LISIS TUMORAL

PARÁMETRO METABÓLICO	PUNTO DE CORTE DIAGNÓSTICO CAIRO-BISHOP	CAMBIO RESPECTO AL BASAL	RIESGO CLÍNICO PRINCIPAL
Ácido Úrico Plasmático	≥ 8.0 mg/dL (≥ 476 umol/L)	Aumento del 25% sobre el basal	Nefropatía aguda por cristales de urato en túbulos
Potasio Sérico	≥ 6.0 mEq/L (≥ 6.0 mmol/L)	Aumento del 25% sobre el basal	Arritmias ventriculares malignas, FV y paro en diástole
Fósforo Sérico	≥ 4.5 mg/dL (≥ 1.45 mmol/L en adultos)	Aumento del 25% sobre el basal	Precipitación de sales de fosfato cálcico e injuria renal
Calcio Sérico Corregido	≤ 7.0 mg/dL (≤ 1.75 mmol/L)	Disminución del 25% sobre el basal	Tetania, signo de Chvostek/Trousseau, convulsiones y arritmias

TRAMPAS EUNACOM

clase hem-22

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Burkitt o LLA > 100.000 antes de quimioterapia	Hiperhidratación + rasburicasa	Solo alopurinol
Lisis tumoral con déficit de G6PD	Alopurinol + hidratación	Rasburicasa
Lisis con K 6,8 y QRS ancho	Gluconato de calcio EV primero	Esperar la diálisis

REGLA DE ORO **Suben úrico, potasio y fósforo** — Baja el calcio: lo arrastra el fósforo

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **76–83** (págs. 16–17) · solucionario págs. 42–43.

Clase 8.22 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · URGENCIAS ONCOHEMATOLÓGICAS, TROMBOFILIAS Y MEDICINA TRANSFUSIONAL

8.23 Trombofilias Hereditarias (Factor V Leiden, Protrombina G20210A) y SAF: Cuándo Estudiar y Manejo

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
5 preguntas reales 2013–2025

1.08.1.019	Trombofilias	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar	
1.11.1.021	Síndrome antifosfolípi...	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar	
1.08.4.006	Estudio de trombofilia	Emplea informe	
1.08.3.012	Tratamiento anticoagulante	Conocimiento general	

LO QUE TE PREGUNTAN

- La mutación del Factor V Leiden (resistencia a proteína C activada) es la trombofilia hereditaria más común.
- El déficit de antitrombina III es la trombofilia genética más trombogénica y genera resistencia a la heparina.
- El estudio funcional de trombofilia no debe realizarse durante la fase aguda de trombosis ni bajo anticoagulantes.
- **Criterios de Sydney para SAF**: trombosis vascular o morbilidad obstétrica más anticuerpos antifosfolípidos positivos x 2 en >**12 semanas**.
- El Anticoagulante Lúpico produce prolongación paradójica del TTPK in vitro que no corrige con plasma normal.

ALGORITMO · TROMBOFILIAS: A QUIÉN ESTUDIAR Y CÓMO TRATAR

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

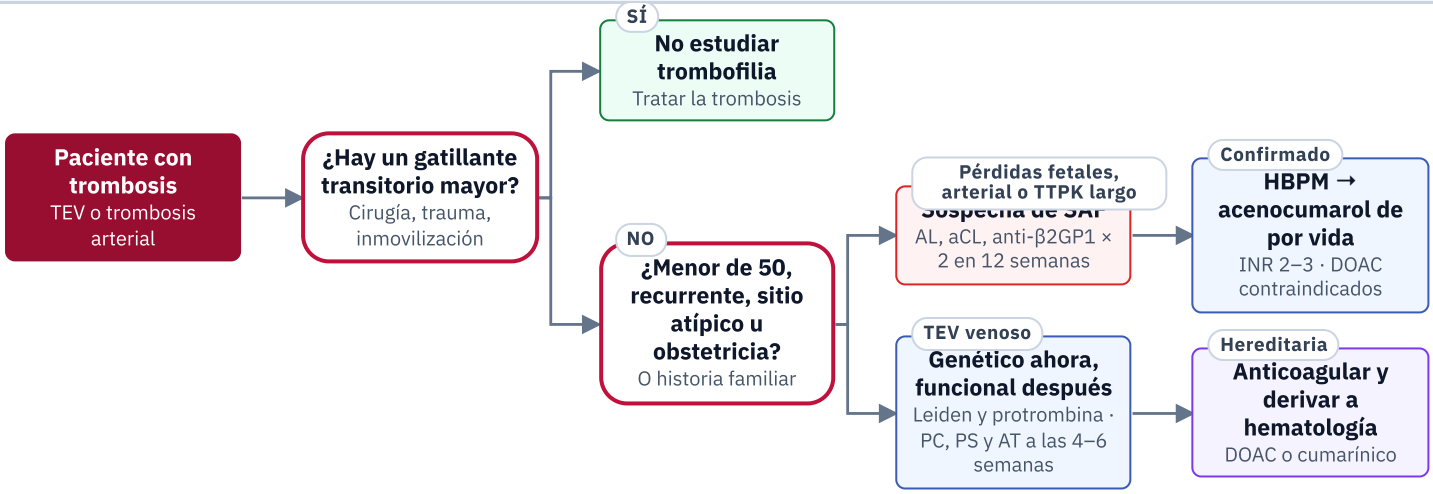


TABLA 8.23 · TROMBOFILIAS HEREDITARIAS VS SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO: DIAGNÓSTICO Y TERAPIA

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE HEM-23

CARACTERÍSTICA	FACTOR V LEIDEN (RESISTENCIA A PCA)	DEFICIENCIA DE ANTITROMBINA III	SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO (SAF)
Naturaleza de la Trombofilia	Hereditaria (autosómica dominante)	Hereditaria (autosómica dominante)	Adquirida autoinmune (primaria o LES)
Frecuencia Poblacional	La más común en caucásicos (3-5% portadores)	Rara (< 0.02% en población general)	La trombofilia adquirida más frecuente
Tipo de Trombosis	Predominantemente Venosa (TVP / TEP)	Venosa profunda severa recurrente	Venosa (TVP) y Arterial (ACV, infarto, gangrena)
Morbilidad Obstétrica	Riesgo leve a moderado de aborto	Riesgo moderado de pérdida fetal	Abortos recurrentes <10 sem, muerte fetal >10 sem
Prueba Diagnóstica	Resistencia a PCa / PCR mutación G1691A	Actividad funcional de antitrombina en plasma	Anticoagulante lúpico, Anti-cardiolipina, Anti-B2GP1
Anticoagulante de Elección	DOACs (Rivaroxabán/Apixabán) o Cumarínicos	DOACs o Cumarínicos (Resistencia a heparina)	ACENOCUMAROL / WARFARINA (INR 2-3); ¡DOACs prohibidos!

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase hem-23

	FACTOR V LEIDEN	DÉFICIT DE ANTITROMBINA	SAF
Origen	Hereditario, AD	Hereditario, AD	Adquirido autoinmune

REGLA DE ORO **Factor V Leiden: la más frecuente** — Resistencia a la proteína C activada

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **84–87** (pág. 17) · solucionario págs. 43–44.

Clase 8.23 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · URGENCIAS ONCOHEMATOLÓGICAS, TROMBOFILIAS Y MEDICINA TRANSFUSIONAL

8.24 Medicina Transfusional y Manejo de Hemocomponentes: Glóbulos Rojos, Plaquetas, Plasma y Reacciones Adversas

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

1.08.3.005	Indicaciones de uso de componentes ...	Conocimiento general	1.08.3.011	Transfusión y sus complicaciones	Conocimiento general

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Estrategia restrictiva**: transfundir glóbulos rojos con Hb < **7.0 g/dL** en pacientes hospitalizados estables.
- En síndrome coronario agudo o shock la meta de hemoglobina es más liberal: mantener Hb > **8.0 a 9.0 g/dL**.
- Una unidad de concentrados de glóbulos rojos (CGR) eleva la hemoglobina en **1 g/dL** y el hematocrito en **3%**.
- Umbral de transfusión profiláctica de plaquetas en falla medular: < 10.000/uL; en cirugías mayores: < 50.000/uL.
- **Ante cualquier reacción transfusional aguda**: DETENER LA TRANSFUSIÓN DE INMEDIATO y mantener vía permeable.

ALGORITMO · REACCIÓN TRANSFUSIONAL AGUDA

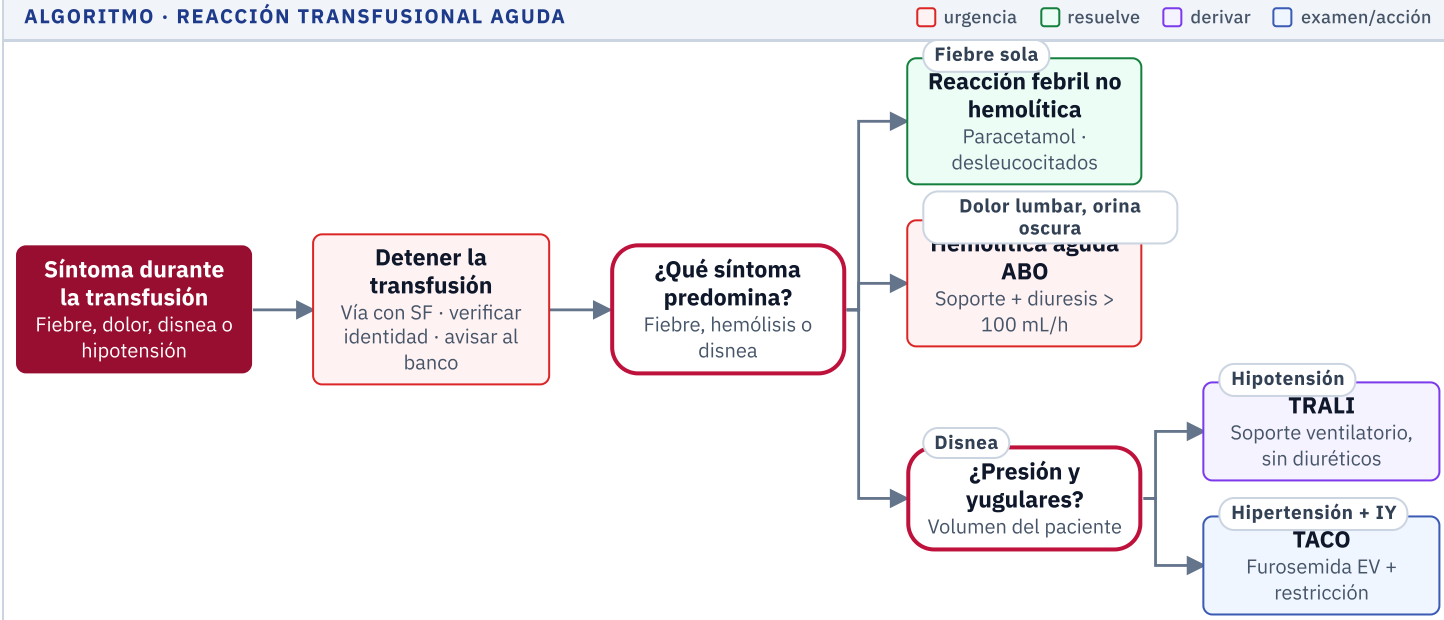


TABLA 8.24 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL RESPIRATORIO: TRALI VS TACO EN MEDICINA TRANSFUSIONAL

PARÁMETRO	TRALI (INJURIA PULMONAR AGUDA)	TACO (SOBRECARGA CIRCULATORIA)
Mecanismo Fisiopatológico	Aumento permeabilidad capilar alveolar (Anticuerpos anti-HLA/HNA)	Hipervolemia hidrostática y sobrecarga ventricular izquierda
Presión Arterial Sistémica	Hipotensión o normal	Hipertensión arterial marcada
Presión Venosa / Yugular	Normal o baja (sin ingurgitación yugular)	Ingurgitación yugular franca (> 10 cmH2O) y reflujo
Auscultación Cardíaca	Normal (sin ritmo de galope)	Ritmo de galope con 3er ruido (R3) audible
Péptido Natriurético (BNP)	Normal o levemente elevado	Marcadamente ELEVADO (> 1.5 a 3 veces el basal)
Respuesta a Furosemida EV	Nula o perjudicial (empeora hipotensión)	MEJORÍA CLÍNICA RÁPIDA Y ESPECTACULAR
Tratamiento Primario	Soporte ventilatorio protector (UCI); oxigenoterapia	Furosemida EV (20-40 mg) + Restricción hídrica + Vasodilatadores

TRAMPAS EUNACOM

clase hem-24

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Hospitalizado estable, Hb 7,5	No transfundir	Transfundir para llegar a 10
Síndrome coronario agudo, Hb 7,8	Transfundir (umbral 8–9)	Aplicar el umbral de 7
Aplasia, plaquetas 15.000, sin fiebre	Observar (umbral 10.000)	Transfundir por el número

REGLA DE ORO **Glóbulos rojos: Hb < 7** — Coronario: 8–9 · hemorragia masiva: no espera

PRACTICA **Libro Gordo Hémato-oncología**, preguntas **88–90** (pág. 17) · solucionario pág. 45.

Clase 8.24 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

Números que tienes que saber

Cortes, dosis, tiempos y metas de los 24 temas, tal como aparecen en el libro y en las clases. Las cifras van en negrita.

DATO	TIPO
BLOQUE 01 · SÍNDROMES ANÉMICOS HIPOPROLIFERATIVOS Y CARENCIALES	
8.1 Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario	pág. 4
Embarazo: Hb < **11 g/dL** — Segundo trimestre: < **10,5 g/dL**	DOSIS
Hombre: Hb < **13 g/dL** — Mujer adulta no embarazada: < **12 g/dL**	DOSIS
8.2 Perfil de Cinética de Hierro: Ferritina, Transferrina, TIBC y Saturación de Transferrina	pág. 5
Ferritina > 500–1.000 ng/mL — IST > **50–60 %**, ferremia muy alta	DOSIS
Still del adulto o activación macrofágica — Ferritina > 3.000 a 10.000 ng/mL	DOSIS
IST < **15–20 %**: ferropenia — IST > **45–50 %**: sobrecarga de hierro	CORTE
8.3 Anemia Ferropénica: Diagnóstico, Algoritmo Causal (Digestivo, Menstrual, Celíaco) y Terapia Oral vs Endovenosa	pág. 6
Ferritina < 30 ng/mL — Confirma sin médula	DOSIS
Ferremia e IST bajos (< **15 %**) — Transferrina alta, RDW elevado	CORTE
Con inflamación: ferritina < 100 + IST < **15 %** — También confirma	CORTE
8.4 Anemia de la Enfermedad Crónica / Inflamación vs Anemia en la Enfermedad Renal Crónica (EPO y Manejo)	pág. 8
Salvo ferropenia asociada — Ferritina < 100 con PCR alta	CORTE
Primero hierro: ferritina > 200, IST > **20 %** — Después EPO	CORTE
8.5 Aplasia Medular e Hipofunción Medular Adquirida vs Fármacos Mielotóxicos	pág. 9
Neutrófilos < 500/µL — Riesgo infeccioso alto	CORTE
Reticulocitos < 20.000/µL o < **1 %** — Médula que no regenera	CORTE
BLOQUE 02 · ANEMIAS MACROCÍTICAS, HEMOLÍTICAS Y HEMOGLOBINOPATÍAS	
8.6 Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato	pág. 10
B12 < 200 pg/mL — Déficit confirmado	DOSIS
Folato intraeritrocitario < 150 ng/mL — Déficit de folato	DOSIS
Ácido fólico **1 a 5 mg**/día oral — Por **3 a 4 meses**	DOSIS
8.7 Anemia Hemolítica Autoinmune (AHAI: Anticuerpos Calientes IgG vs Crioaglutininas IgM) y Test de Coombs Directo	pág. 11
Hb < 7, disnea de reposo, dolor torácico — LDH > **1.500 UI**/L	DOSIS
Rituximab anti-CD20 — **375 mg**/m² semanal por **4 semanas**	DOSIS
8.8 Esferocitosis Hereditaria, Déficit de G6PD (Favismo) y Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN)	pág. 13
CHCM mayor de **36 g/dL** — El glóbulo está deshidratado	DOSIS
No durante la crisis — Esperar **2 a 3 meses**	TIEMPO
8.9 Talasemias (Rasgo Beta vs Mayor) y Drepanocitosis / Anemia Falciforme (HbS)	pág. 14
Si es < 13 orienta a talasemia; si > 13 a ferropenia.	CORTE
HbA2 mayor de **3,5 %** — Habitualmente **4 a 7 %**	CORTE
8.10 Microangiopatías Trombóticas (MAT): PTT (Déficit ADAMTS13 / Plasmaféresis) vs SHU	pág. 15
Adulto + cerebro fluctuante — PTT: ADAMTS13 < **10 %**	CORTE
Si se retrasa: plasma fresco — **15 a 30 mL/kg**/día	DOSIS
Anemia hemolítica microangiopática — LDH > 1.000, esquistocitos > **1–2 %**	CORTE
BLOQUE 03 · HEMOSTASIA PRIMARIA, PLAQUETAS Y COAGULOPATÍAS	
8.11 Fisiología de la Hemostasia y Evaluación de Laboratorio: Recuento Plaquetario, TP/INR, TTPK y Fibrinógeno	pág. 16
Monitorizar heparina no fraccionada — Meta: **1,5 a 2,5 veces** el control	META
Factores VII, X, V, II y fibrinógeno — Normal: 11–13,5 s o **70–100 %**	CORTE

Números que tienes que saber · continuación

DATO	TIPO
8.12 Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del Adulto y Niño: Criterios, Sangrado y Terapia GES	pág. 17
Plaquetas muy bajas — A menudo < 20.000/µL	CORTE
Remite sola en > **80 %** — En **3 a 6 meses**, sin secuelas	CORTE
Asintomático o petequias aisladas — Con plaquetas > 30.000/µL	CORTE
8.13 Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand	pág. 19
Ausencia total, autosómica recesiva — Factor VIII < **1–2 %**	CORTE
SNC o politrauma: meta **100 %** — **50 UI**/kg, antes del TAC	DOSIS
1 UI/kg sube el IX un **1 %** — Hemartrosis 40–50 · vital **100 UI**/kg	DOSIS
8.14 Coagulopatías Adquiridas: Hepatopatía Crónica, Déficit de Vitamina K y Manejo de Anticoagulantes	pág. 21
Sin sangrado, INR > 10 — Vitamina K oral **2,5–5 mg**	DOSIS
Anti-Xa: andexanet alfa — O CCP **50 UI**/kg si no hay	DOSIS
8.15 Coagulación Intravascular Diseminada (CID): Criterios ISTH, Sepsis/Obstetricia y Manejo	pág. 22
Crioprecipitado — Fibrinógeno < **100–150 mg/dL**	DOSIS
Plaquetas — Meta > 50.000 si sangra · > 20.000 si no	META
BLOQUE 04 · ONCOHEMATOLOGÍA: NEOPLASIAS MIELOIDES Y LINFOIDES	
8.16 Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante	pág. 23
Hemograma inicia, mielograma confirma — **≥ 20%** de blastos	CORTE
Protocolo PINDA — Sobrevida libre de enfermedad > **85–90%**	CORTE
Aplasia de **3 a 4 semanas** — Soporte intensivo	TIEMPO
8.17 Leucemias Crónicas: Leucemia Mieloide Crónica (LMC, BCR-ABL) vs Leucemia Linfática Crónica (LLC)	pág. 25
Linfocitos B **≥ 5.000/µL** — Persistentes al menos **3 meses**	CORTE
LLC temprana: observar — Tratar solo si Hb < 10 o plaquetas < 100.000	CORTE
La leucemia del adulto mayor — Sobre **70 años**; rara bajo 40	CORTE
8.18 Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular)	pág. 26
Síntomas B — Fiebre > 38, sudoración, peso > **10%** en **6 meses**	CORTE
Indolora, gomosa, > **2 cm**, > **4–6 semanas** — Sospechar linfoma	CORTE
ABVD cura más del **85%** — GES 38	CORTE
8.19 Mieloma Múltiple: Criterios CRAB, Pico Monoclonal, Gammapatía Monoclonal Incierta (GMSI)	pág. 28
R: creatinina > **2 mg/dL** — O clearance < **40 mL**/min	DOSIS
C: calcio > **11 mg/dL** — O más de 1 sobre el límite normal	DOSIS
8.20 Neoplasias Mieloproliferativas (Policitemia Vera JAK2, TE, Mielofibrosis) y Mielodisplasia	pág. 29
TE: plaquetas > 450.000 — Sangra o trombosa	CORTE
Hb > 16,5 (H) · > 16 (M) — O Hto > **49%** (H) · > **48%** (M)	CORTE
BLOQUE 05 · URGENCIAS ONCOHEMATOLÓGICAS, TROMBOFILIAS Y MEDICINA TRANSFUSIONAL	
8.21 Neutropenia Febril en Oncología: Estratificación MASCC, Monoterapia Antipseudomónica y Urgencia Médica	pág. 30
MASCC **≥ 21**: oral ambulatorio — MASCC < 21: hospitalizar	CORTE
Cefepime **2 g** c/**8 h** EV — En infusión extendida	DOSIS
Hemocultivos + antibiótico EV < **60 min** — Nunca tacto rectal	CORTE
8.22 Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular	pág. 31
Ácido úrico **≥ 8 mg/dL** — Potasio **≥ 6 mEq/L**	DOSIS
Fósforo **≥ 4,5 mg/dL** (adulto) — **≥ 6,5 en** niños	DOSIS
Calcio corregido **≤ 7 mg/dL** — O cambio de **25%** sobre el basal	DOSIS

Números que tienes que saber · continuación

DATO	TIPO
8.23 Trombofilias Hereditarias (Factor V Leiden, Protrombina G20210A) y SAF: Cuándo Estudiar y Manejo	pág. 32
Anticardiolipina IgG o IgM — Títulos moderados o altos, > 40 GPL o MPL	CORTE
Riesgo de TEV **4 a 8 veces** mayor — En heterocigotos	CORTE
Positivo en 2 ocasiones — Separadas por al menos **12 semanas**	TIEMPO
8.24 Medicina Transfusional y Manejo de Hemocomponentes: Glóbulos Rojos, Plaquetas, Plasma y Reacciones Adversas	pág. 33
Estable: Hb < **7 g/dL** — En sala o UCI · meta 7 a 8	DOSIS
< 10.000: falla medular estable — Profilaxis	CORTE

Fármacos de primera línea

Esquemas de elección por enfermedad, tomados de las tarjetas de tratamiento de cada clase. Al final de la sección, las garantías GES.

SITUACIÓN	FÁRMACO / ESQUEMA	DETALLE	
8.3 **Anemia Ferropénica: Diagnóstico, Algoritmo Causal (Digestivo, Menstrual, Celíaco) y Terapia Oral vs Endovenosa**			pág. 6
Menos dosis, mejor absorción · Esquema actual	**40 a 100 mg de hierro elemental al día**	1 comprimido de **200 mg** = **40–60 mg** elemental	
Menos dosis, mejor absorción · Esquema actual	**En ayunas, con vitamina C**	Mantiene el hierro ferroso soluble	
¿Cuándo pasar a la vena? · Preparados modernos	**Carboximaltosa férrica o hierro sacarato**	**500 a 1.000 mg** en **15 a 30 minutos**	
8.5 **Aplasia Medular e Hipofunción Medular Adquirida vs Fármacos Mielotóxicos**			pág. 9
Fármacos mielotóxicos	**Antitiroideos: tiamazol y propiltiouracilo**	Mujer joven con Graves	
8.6 **Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato**			pág. 10
Déficit de folato	**Metotrexato, trimetoprima, pirimetamina**	Fenitoína, fenobarbital, carbamazepina	
8.7 **Anemia Hemolítica Autoinmune (AHAI: Anticuerpos Calientes IgG vs Crioaglutininas IgM) y Test de Coombs Directo**			pág. 11
Primera línea · AHAI caliente	**Prednisona 1 a 1,5 mg/kg/día**	Responde el **70 a 80 %** en **7 a 14 días**	
Primera línea · AHAI caliente	**Ácido fólico 5 mg/día**	La médula acelerada consume folato	
Opciones	**Rituximab anti-CD20**	**375 mg**/m² semanal por **4 semanas**	
Opciones · Esplenectomía electiva	**Vacunas 2 semanas antes**		
8.8 **Esferocitosis Hereditaria, Déficit de G6PD (Favismo) y Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN)**			pág. 13
Esplenectomía	**Vacunar antes**	Neumococo, meningococo y Haemophilus	
Casos graves	**Eculizumab o ravulizumab**	Anticuerpos anti-C5 del complemento	
8.9 **Talasemias (Rasgo Beta vs Mayor) y Drepanocitosis / Anemia Falciforme (HbS)**			pág. 14
Anemia de Cooley · Complicación	**Quelantes de hierro**	Deferoxamina o deferasirox	
Crisis vasooclusiva en urgencias · Urgencia	**Opioides de inmediato**	Morfina EV o fentanilo	
Crisis vasooclusiva en urgencias · Urgencia	**Ceftriaxona si hay infección**	Cubre neumococo	
8.10 **Microangiopatías Trombóticas (MAT): PTT (Déficit ADAMTS13 / Plasmaféresis) vs SHU**			pág. 15
Plasmaféresis ya, y nunca plaquetas · PTT	**Corticoides en dosis altas**	Metilprednisolona EV o prednisona **1 mg/kg**/día	
8.11 **Fisiología de la Hemostasia y Evaluación de Laboratorio: Recuento Plaquetario, TP/INR, TTPK y Fibrinógeno**			pág. 16
TTPK · Para qué se usa	**Monitorizar heparina no fraccionada**	Meta: **1,5 a 2,5 veces** el control	
8.13 **Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand**			pág. 19
Von Willebrand · Desmopresina	**Efecto antidiurético; limitar líquidos**		
8.14 **Coagulopatías Adquiridas: Hepatopatía Crónica, Déficit de Vitamina K y Manejo de Anticoagulantes**			pág. 21
Acenocumarol y warfarina · Mecanismo	**Epóxido reductasa de la vitamina K**		
Antídotos	**Dabigatrán: idarucizumab**	**5 g** EV · neutraliza en minutos	
Antídotos	**Heparina no fraccionada: protamina**	**1 mg** neutraliza **100 UI**	
8.16 **Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante**			pág. 23
LLA · Quimioterapia intensiva	**Vincristina, dexametasona, L-asparaginasa, daunorrubicina**		
LLA · Quimioterapia intensiva	**Metotrexato, citarabina y dexametasona**		
Quimioterapia intratecal · La da el hematólogo por punción lumbar	**Metotrexato, citarabina y corticoide**		

Fármacos de primera línea · continuación

SITUACIÓN	FÁRMACO / ESQUEMA	DETALLE	
8.24 Medicina Transfusional y Manejo de Hemocomponentes: Glóbulos Rojos, Plaquetas, Plasma y Reacciones Adversas (cont.)			pág. 33
Quimioterapia intratecal · Tratamiento si hay infiltración meníngea	**Cefalea, pares craneales, blastos en el LCR**		
8.18 Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular)			pág. 26
Esquemas garantizados y su toxicidad · Hodgkin	**Doxorrubicina, bleomicina, vinblastina, dacarbazina**	± radioterapia del campo comprometido	
Esquemas garantizados y su toxicidad · Hodgkin	**Bleomicina: pulmón · doxorrubicina: corazón**	Toxicidades a vigilar	
Esquemas garantizados y su toxicidad · No Hodgkin agresivo B	**Rituximab + CHOP**	Ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina, prednisona	
Esquemas garantizados y su toxicidad · No Hodgkin agresivo B	**Vincristina: neuropatía · rituximab: VHB**	Reacción infusional, reactivar hepatitis B	
8.19 Mieloma Múltiple: Criterios CRAB, Pico Monoclonal, Gammapatía Monoclonal Incierta (GMSI)			pág. 28
Inducción	**Bortezomib + lenalidomida + dexametasona**	VRd; alternativa CyBorD	
Hueso	**Ácido zoledrónico o denosumab**	Para las lesiones óseas	
8.20 Neoplasias Mieloproliferativas (Policitemia Vera JAK2, TE, Mielofibrosis) y Mielodisplasia			pág. 29
Policitemia vera · Todos los pacientes	**Aspirina 100 mg/día**	Asociada a las sangrías	
8.21 Neutropenia Febril en Oncología: Estratificación MASCC, Monoterapia Antipseudomónica y Urgencia Médica			pág. 30
Monoterapia antipseudomónica · Alto riesgo	**Cefepime 2 g c/8 h EV**	En infusión extendida	
Monoterapia antipseudomónica · Alto riesgo	**O piperacilina/tazobactam 4,5 g c/6 h EV**	Alternativa de igual nivel	
8.24 Medicina Transfusional y Manejo de Hemocomponentes: Glóbulos Rojos, Plaquetas, Plasma y Reacciones Adversas			pág. 33
La más frecuente y la más benigna · Tratar y prevenir	**Paracetamol**	Responde a antipiréticos	

GES de Hematología & Hemostasia

Garantías Explícitas en Salud que aparecen en los temas de esta especialidad: el EUNACOM pregunta la edad, el examen y el plazo que garantizan.

GES Garantía Explícita en Salud (GES): Prevención y Tratamiento Integral en Niños y Gestantes

Tema **8.3** · Anemia Ferropénica: Diagnóstico, Algoritmo Causal (Digestivo, Menstrual, Celíaco) y Terapia Oral vs Endovenosa
`1.08.1.002` · `2.01.1.031`
pág. 6

GES Garantía Explícita en Salud (GES N° 1): Insuficiencia Renal Crónica Terminal

Tema **8.4** · Anemia de la Enfermedad Crónica / Inflamación vs Anemia en la Enfermedad Renal Crónica (EPO y Manejo)
`1.08.1.001` · `1.09.1.004`
pág. 8

GES Garantía Explícita en Salud (GES N° 32): Hemofilia y otras coagulopatías congénitas

Tema **8.13** · Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand
`1.08.1.006` · `1.08.2.003` · `1.08.4.005`
pág. 19

GES Garantía Explícita en Salud (GES N° 37 y N° 8): Leucemias en personas de 15 años y más / Menores de 15 años

Tema **8.16** · Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante
`1.08.1.009` · `1.08.4.009` · `2.01.1.032`
pág. 23

Fármacos de primera línea · continuación

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 37): Leucemia en personas de 15 años y más (LMC)**

Tema **8.17** · Leucemias Crónicas: Leucemia Mieloide Crónica (LMC, BCR-ABL) vs Leucemia Linfática Crónica (LLC)
`1.08.1.010` · `1.08.1.014`
pág. **25**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 38 y N° 8): Linfomas en personas de 15 años y más / Menores de 15 años**

Tema **8.18** · Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular)
`1.08.1.011` · `1.08.5.002` · `2.01.1.033`
pág. **26**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 72): Mieloma Múltiple en personas de 15 años y más**

Tema **8.19** · Mieloma Múltiple: Criterios CRAB, Pico Monoclonal, Gammapatía Monoclonal Incierta (GMSI)
`1.08.1.007` · `1.08.4.004`
pág. **28**

GES **Garantía Explícita en Salud: Urgencia Vital en Paciente Oncológico GES**

Tema **8.21** · Neutropenia Febril en Oncología: Estratificación MASCC, Monoterapia Antipseudomónica y Urgencia Médica
`1.08.2.006` · `1.04.1.020`
pág. **30**

Sin garantía GES específica (16 temas): 8.1 · 8.2 · 8.5 · 8.6 · 8.7 · 8.8 · 8.9 · 8.10 · 8.11 · 8.12 · 8.14 · 8.15 · 8.20 · 8.22 · 8.23 · 8.24. Revisa igual la norma MINSAL que cita cada página.

Plan de repaso de 7 días

Los temas van de mayor a menor prioridad (★ según preguntas reales EUNACOM 2013–2025). Cada día: lee la página del tema, recorre su algoritmo y haz sus preguntas del Libro Gordo; corrige con el solucionario.

DÍA 1

4 temas · ★★★

- ★★★ **8.12** Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del Adulto y Niño: Criterios, Sangrado y Terapia GES — 17
- ★★★ **8.6** Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato — 10
- ★★★ **8.10** Microangiopatías Trombóticas (MAT): PTT (Déficit ADAMTS13 / Plasmaféresis) vs SHU — 15
- ★★★ **8.16** Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante — 23

Practica: Libro Gordo Hémato-oncología, preguntas 19–28, 38, 41–43, 55–59.

DÍA 2

4 temas · ★★★

- ★★★ **8.13** Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand — 19
- ★★★ **8.3** Anemia Ferropénica: Diagnóstico, Algoritmo Causal (Digestivo, Menstrual, Celíaco) y Terapia Oral vs Endovenosa — 6
- ★★★ **8.18** Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular) — 26
- ★★★ **8.22** Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular — 31

Practica: Libro Gordo Hémato-oncología, preguntas 13–14, 44–49, 63–65, 76–83.

DÍA 3

4 temas · ★★

- ★★☆ **8.23** Trombofilias Hereditarias (Factor V Leiden, Protrombina G20210A) y SAF: Cuándo Estudiar y Manejo — 32
- ★★☆ **8.17** Leucemias Crónicas: Leucemia Mieloide Crónica (LMC, BCR-ABL) vs Leucemia Linfática Crónica (LLC) — 25
- ★★☆ **8.21** Neutropenia Febril en Oncología: Estratificación MASCC, Monoterapia Antipseudomónica y Urgencia Médica — 30
- ★★☆ **8.2** Perfil de Cinética de Hierro: Ferritina, Transferrina, TIBC y Saturación de Transferrina — 5

Practica: Libro Gordo Hémato-oncología, preguntas 8–12, 60–62, 73–75, 84–87.

DÍA 4

4 temas · ★★

- ★★☆ **8.7** Anemia Hemolítica Autoinmune (AHAI: Anticuerpos Calientes IgG vs Crioaglutininas IgM) y Test de Coombs Directo — 11
- ★★☆ **8.8** Esferocitosis Hereditaria, Déficit de G6PD (Favismo) y Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN) — 13
- ★★☆ **8.14** Coagulopatías Adquiridas: Hepatopatía Crónica, Déficit de Vitamina K y Manejo de Anticoagulantes — 21
- ★★☆ **8.19** Mieloma Múltiple: Criterios CRAB, Pico Monoclonal, Gammapatía Monoclonal Incierta (GMSI) — 28

Practica: Libro Gordo Hémato-oncología, preguntas 29–34, 50–52, 66–69.

DÍA 5

4 temas · ★

- ★☆☆ **8.9** Talasemias (Rasgo Beta vs Mayor) y Drepanocitosis / Anemia Falciforme (HbS) — 14
- ★☆☆ **8.11** Fisiología de la Hemostasia y Evaluación de Laboratorio: Recuento Plaquetario, TP/INR, TTPK y Fibrinógeno — 16
- ★☆☆ **8.1** Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario — 4
- ★☆☆ **8.4** Anemia de la Enfermedad Crónica / Inflamación vs Anemia en la Enfermedad Renal Crónica (EPO y Manejo) — 8

Practica: Libro Gordo Hémato-oncología, preguntas 1–7, 15–16, 35–36, 39–40.

DÍA 6

4 temas · ★

- ★☆☆ **8.5** Aplasia Medular e Hipofunción Medular Adquirida vs Fármacos Mielotóxicos — 9
- ★☆☆ **8.15** Coagulación Intravascular Diseminada (CID): Criterios ISTH, Sepsis/Obstetricia y Manejo — 22
- ★☆☆ **8.20** Neoplasias Mieloproliferativas (Policitemia Vera JAK2, TE, Mielofibrosis) y Mielodisplasia — 29
- ★☆☆ **8.24** Medicina Transfusional y Manejo de Hemocomponentes: Glóbulos Rojos, Plaquetas, Plasma y Reacciones Adversas — 33

Practica: Libro Gordo Hémato-oncología, preguntas 17–18, 53–54, 70–72, 88–90.

DÍA 7

- Relee «**Números que tienes que saber**» y «**Fármacos de primera línea**» pág. 34
- Repasa solo las **Trampas EUNACOM** y la **Regla de oro** de los temas ★★★: 8.3 · 8.6 · 8.10 · 8.12 · 8.13 · 8.16 · 8.18 · 8.22
- Simulacro: las **90 preguntas** del Libro Gordo Hémato-oncología en 120 minutos; vuelve a la página de cada tema que falles.

Índice por prioridad ★

El número a la izquierda es la cantidad de preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) en los códigos Perfil V3 del tema.

★★★ Prioridad alta · 8 temas

13 8.12. Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del Adulto y Niño: Criterios, Sangrado y Terapia GES 17

11 8.6. Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato 10

11 8.10. Microangiopatías Trombóticas (MAT): PTT (Déficit ADAMTS13 / Plasmaféresis) vs SHU 15

11 8.16. Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante GES 23

10 8.13. Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand GES 19

8 8.3. Anemia Ferropénica: Diagnóstico, Algoritmo Causal (Digestivo, Menstrual, Celíaco) y Terapia Oral vs Endovenosa GES 6

7 8.18. Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular) GES 26

6 8.22. Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular 31

★★ Prioridad media · 8 temas

5 8.23. Trombofilias Hereditarias (Factor V Leiden, Protrombina G20210A) y SAF: Cuándo Estudiar y Manejo 32

4 8.17. Leucemias Crónicas: Leucemia Mieloide Crónica (LMC, BCR-ABL) vs Leucemia Linfática Crónica (LLC) GES 25

4 8.21. Neutropenia Febril en Oncología: Estratificación MASCC, Monoterapia Antipseudomónica y Urgencia Médica GES 30

3 8.2. Perfil de Cinética de Hierro: Ferritina, Transferrina, TIBC y Saturación de Transferrina 5

3 8.7. Anemia Hemolítica Autoinmune (AHAI: Anticuerpos Calientes IgG vs Crioaglutininas IgM) y Test de Coombs Directo 11

3 8.8. Esferocitosis Hereditaria, Déficit de G6PD (Favismo) y Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN) 13

3 8.14. Coagulopatías Adquiridas: Hepatopatía Crónica, Déficit de Vitamina K y Manejo de Anticoagulantes 21

3 8.19. Mieloma Múltiple: Criterios CRAB, Pico Monoclonal, Gammapatía Monoclonal Incierta (GMSI) GES 28

★ Prioridad baja · 8 temas

2 8.9. Talasemias (Rasgo Beta vs Mayor) y Drepanocitosis / Anemia Falciforme (HbS) 14

2 8.11. Fisiología de la Hemostasia y Evaluación de Laboratorio: Recuento Plaquetario, TP/INR, TTPK y Fibrinógeno 16

1 8.1. Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario 4

1 8.4. Anemia de la Enfermedad Crónica / Inflamación vs Anemia en la Enfermedad Renal Crónica (EPO y Manejo) GES 8

1 8.5. Aplasia Medular e Hipofunción Medular Adquirida vs Fármacos Mielotóxicos 9

1 8.15. Coagulación Intravascular Diseminada (CID): Criterios ISTH, Sepsis/Obstetricia y Manejo 22

1 8.20. Neoplasias Mieloproliferativas (Policitemia Vera JAK2, TE, Mielofibrosis) y Mielodisplasia 29

1 8.24. Medicina Transfusional y Manejo de Hemocomponentes: Glóbulos Rojos, Plaquetas, Plasma y Reacciones Adversas 33